

Anlagenkonvolut zum
Kurzprotokoll der 3. Sitzung des
Ausschusses für Gesundheit am
25. Juni 2025

Statement des BfHD

„Stellungnahme zum neuen Hebammenhilfvertrag nach der Schiedsstelle vom 2. April 2025, mit dem Schwerpunkt Dienstbeleghebammen“

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Möglichkeit als 1. Vorsitzende des BfHD hier als Sachverständige sprechen zu können.

Das erklärte Ziel aller Beteiligten am neuen Hebammenhilfvertrag war, neben der Stärkung der individuellen Geburtshilfe, die dringend notwendige Aufwertung aller Hebammenleistungen.

Ein Ausgleich des momentan bestehenden Einkommensgefälles innerhalb der freiberuflichen Hebammen und ihrer vielfältigen Arbeitssituationen sollte erwirkt werden. Die erreichte Stärkung der außerklinischen Geburtshilfe und der Begleitbeleghebammen stellt einen Anreiz dar, dieses Angebot auszubauen und der gesetzlich zugesicherten freien Wahl des Geburtsortes eine Chance zu geben.

Dies darf aber nicht auf Kosten derjenigen gehen, die bisher für viel Arbeit gutes Geld erwirtschaften konnten. Stichwort Dienstbeleghebammen.

Der Kompromiss, sich ausgehend von den sehr gegensätzlichen Forderungen (50€ vs. 88€) auf 74,28€ für den Außerklinischen Bereich zu einigen, und damit unter der Grundlohnsummensteigerung zu bleiben (in der Klinik sind es ohne Zuschläge zukünftig rund 60€ pro Stunde für die Betreuung einer Versicherten), war notwendig, um den neuen, von vielen freiberuflichen Hebammen erhofften Vertrag zeitnah umsetzen zu können, und diesen mit einer sehr kurzen Laufzeit zu versehen. Dass damit das Ende der Fahnenstange auf dem Verhandlungsweg nach über 4 Jahren vorerst erreicht war, darf nur eine vorübergehende Lösung sein. Denn, wir Hebammen haben mehr verdient!

Klar war aber auch unsere Bedingung, um dem Vertrag in der Schiedsstelle überhaupt zustimmen zu können: Keine Kollegin darf mit dem neuen Vertrag schlechter gestellt werden als bisher. Für den Fall, dass eine Verschlechterung der Einkommenssituation eintritt, haben wir uns für die im Vertrag verankerte Protokollnotiz stark gemacht. Diese neu eingerichtete Arbeitsgruppe muss Lösungen erarbeiten, und den Vertrag evaluierend begleiten und prospektiv gedacht sein, und nicht erst retrospektiv greifen. Dafür werben wir hier und auch beim GKV-SV, damit es eben zu keinen Versorgungsengpässen kommt.

Für den Bereich der Dienstbeleghebammen zeichnet sich bereits jetzt großer Widerstand gegen den neuen Vertrag ab und viele Kolleginnen befürchten Einkommenseinbußen. Dies gilt es, mit allen Vertragspartner innerhalb der Selbstverwaltung zügig unabhängig zu prüfen und gegebenenfalls schnellstmöglich zu handeln (dafür gibt es das Tool der Änderungsvereinbarungen - der gesamte Vertrag muss dafür nicht aufgeschnürt oder gekippt werden), und nicht erst mit einem neuen Vertrag nach 2027, entgegen zu steuern.

Aber: Mediale Panikmache, wie sie seit dem Schiedsspruch massiv geschürt wird, hilft uns überhaupt nicht weiter. Indem weiterhin Ängste bei den Kolleginnen geschürt werden,

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

vergeht kostbare Zeit, durch Umstrukturierungen in der Arbeits- und Abrechnungsweise jeder einzelnen Hebamme dem neuen Hebammenhilfvertrag ins Leben zu verhelfen. Das Problem der Doppelabrechnungen (Klinik und Beleghebamme, Bsp Ambulanz oder Notfälle) kann nicht mit dem Hebammenhilfvertrag nach 134a SGB V geheilt werden, hier brauchen wir Unterstützung aus der Politik und die Zusagen der Krankenhausgesellschaft, in einen Diskurs zu gehen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Eine Übernahme der „Leerlaufstunden“, die der Hebamme von der Klinik bezahlt wird, wäre bereits eine große Entlastung – die Kassen dürfen nur erbrachte Leistungen an den Versicherten vergüten. Eine weitere Idee, die wir mit den Kolleginnen kommunizieren, ist das Auslagern der Ambulanz aus dem Kreißaal in einen separaten Raum, der Hebammenambulanz. Dann kann die Hebamme zum 100%-Satz alles abrechnen und der Kreißaal ist entlastet. Diese Lösungen wurden bereits im Laufe der Verhandlungen angedacht (ohne den DHV, der ab September 2024 den Verhandlungen bis zum Schiedsstellentermin fernblieb) und sind Teil des Arbeitsauftrags der in der Protokollnotiz eingesetzten Arbeitsgruppe.

Jede Frau hat laut dem SGB 5 einen Anspruch auf Hebammenhilfe, unabhängig davon, wo sie auf die Hebamme trifft. Ob in ihrem Zuhause, im Geburtshaus, in einer Praxis oder in einem Krankenhaus. In vielen Kreißsälen arbeiten freiberufliche Hebammen, die sich gerade sehr gut überlegen, ob sie und wenn ja wie, nach dem 1. November weiterarbeiten.

Bei der Frage, ob es weitere Möglichkeiten für nachsteuerbare Lösungen für absehbare Probleme in der Flächenversorgung gibt, dürfen wir nicht erst in der Zukunft darauf schauen, was besser gemacht werden könnte. Dies geht neben der beruflichen und wirtschaftlichen Perspektive der Kolleginnen auch auf die Kosten der Versorgung Schwangerer und Gebärender.

Wir setzen eine große Hoffnung in die konstruktive Arbeit der dazu installierten Arbeitsgruppe (das war das Ziel der Protokollnotiz in der Schiedsstelle) mit dem Ziel, Hilfestellungen für konkrete Verhandlungen mit den Kliniken und notwendige Anpassungen der Arbeits- und Abrechnungsstrukturen schnellstmöglich zu erarbeiten und mit den Kolleginnen zu kommunizieren.

Zum anderen brauchen wir den Rückhalt aus der Politik, um über notwendige Anpassungen des Hebammengesetzes (zuletzt geändert und grundsätzlich reformiert 2019/ 2020) zukünftig wichtige Inhalte (Bsp. Hebammen-Ultraschall, Diagnose und Therapie in der Hebammenarbeit, psycho-soziale Betreuung) in den nächsten Vertrag hinein verhandeln zu können. Dies ist die neben der Selbstverwaltung der Gesundheitsfachberufe die politische Basis, um wichtige Verbesserungen für die Hebammenarbeit durchsetzen zu können. Hier setzen wir auf Sie, meine Damen und Herren Bundestagsabgeordnete.

Hintergrundinformationen zum Fachgespräch Hebammenhilfevertrag und Beleghebammen am 25.06.2025



Deutscher
Hebammen
Verband

Anlässlich des Fachgesprächs zum Hebammenhilfevertrag hat der DHV nachfolgende Informationen zu den Auswirkungen des Schiedsspruchs auf das Beleghebammensystem sowie die Versorgungssicherheit mit klinischer Geburts- und Notfallversorgung zusammengestellt. Auch wenn viele Bereiche im Hebammenhilfevertrag nicht zufriedenstellend gelöst sind, fokussieren sich die nachfolgenden Informationen auf die Teilproblematik des Belegsystems, da hier die Versorgungssicherheit für Mutter und Kind akut bedroht ist. Es besteht das sehr hohe Risiko, dass der Auftrag der Selbstverwaltung, die Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen sicherzustellen, als Folge des Schiedsspruchs zum Hebammenhilfevertrag nicht mehr erfüllt werden kann. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um diese Gefahr abzuwenden.

Themenblock 1: Droht eine signifikante Versorgungslücke, falls Beleghebammen kündigen?

Anteil der Beleghebammen in der bundesweiten Versorgungslandschaft

Bundesland	Gesamt geburts- hilfliche Kliniken	davon Beleg- abteilungen	davon Angestell- tenverhältnis	prozentuale Verteilung	Schließungen seit 2000
Baden- Württemberg	66	20	46	30 %	Zahl liegt aktuell nicht vor
Bayern	92	69	23	75 %	47 (seit 2005)
Berlin	18	1	17	6 %	1
Brandenburg	20	2	18	10 %	5
Bremen	5	0	5	0	0
Hamburg	11	1	10	9 %	3
Hessen	41	9	32	22 %	Zahl liegt aktuell nicht vor
Mecklenburg- Vorpommern	14	3	11	21 %	2
Niedersachsen	57	11	46	22 %	10
Nordrhein- Westfalen	124	18	106	19 %	60
Rheinland-Pfalz	27	5	22	19 %	25
Saarland	6	1	5	17 %	10
Sachsen	31	4	27	13 %	7
Sachsen-Anhalt	17	2	15	12 %	7
Schleswig- Holstein	15	3	12	20 %	17
Thüringen	19	5	14	26 %	5
Bundesweit	563	154	409	27,35 %	Nicht vollständig

Beleghebammenteams be-
treuen bundesweit ca. 20 %
der Geburten. Regional be-
stehen jedoch große Unter-
schiede. Während in Bayern
bis zu 80 % der klinischen
Geburten und der Notfallver-
sorgung durch Beleghebam-
men betreut werden, werden
in Bremen alle klinischen
Geburten durch angestellte
Hebammen betreut.

Zu berücksichtigen ist, dass
neben Maximalversorgern
gerade Kliniken in struktur-
schwachen Regionen auf Be-
leghebammenteams umge-
stellt haben. Ein Grund dafür
ist, dass dieses Modell durch
die hohe Flexibilität der frei-
beruflichen Hebammen
besser geeignet ist, um auf
schwankende Auslastungs-
zahlen zu reagieren. Sie
können dennoch eine 1:1- bis
1:3-Betreuung verlässlich
anbieten.

Viele Bundesländer und
Kommunen haben zusammen mit den Klinikträgern diese Vorteile des Belegsystems in der
Versorgungsplanung genutzt.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Einfluss der fortschreitenden Zentralisierung auf die aktuelle Situation

Während in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen die Versorgungsproblematik schnell ins Auge fällt, können darüber hinaus jedoch auch vermeintlich sichere Kommunen betroffen sein, da ein Dominoeffekt droht. Durch die hohe Quote an geplanten und ungeplanten Kreißaalschließungen der vergangenen Jahre können die wegfallenden Kapazitäten räumlich und personell nicht aufgefangen werden. Das führt zu einer weiteren Überlastung in den verbleibenden Kreißsälen. Als Folge kündigen dort die Fachkräfte. Die Verweildauer von angestellten Hebammen im Beruf beträgt durchschnittlich nur 4 bis 7 Jahre, im Kreißsaal sogar noch deutlich kürzer.

Versorgungsengpass für Mutter und Kind am Beispiel Bayern und Nordrhein-Westfalen



Eckdaten zur klinischen Geburtshilfe mit Beleghebammen

Kliniken schließen mit Teams von Beleghebammen Versorgungsverträge, in denen sie den Auftrag zur Aufrechterhaltung der klinischen Geburtshilfe und Wahrung der Hinzuziehungspflicht an die freiberuflich arbeitenden Hebammen übertragen. Die Hebammen organisieren sich selbstständig im Team und garantieren 24/7 ausreichende Versorgung mit Hebammenhilfe im Kreißsaal. Sie rechnen ihre Leistungen über den Hebammenhilfevertrag nach § 134a SGB V direkt mit den Krankenkassen ab und erhalten darüber hinaus keine Vergütung vom Krankenhaus. Die Kündigungsfristen betragen für das Team, je nach Vertrag, zwischen 3 und 6 Monaten oder länger.

Die Arbeitszufriedenheit in Belegteams ist sehr hoch, ebenso wie die Quote an 1:1-Betreuung. Beleghebammen betreuen in 30 % der Zeit (in Level 1-Kliniken) bis hin zu 60 % der Zeit (in Level 3 und 4 Kliniken) nur eine Frau. In Kliniken mit angestellten Hebammen wird diese Quote bei weitem nicht erreicht. So haben laut IGES-Gutachten¹ zur stationären Hebammenversorgung Hebammen von 2019 lediglich in 2 % der Zeit nur eine Frau betreut. In einem Viertel der Zeit müssen angestellte Hebammen

¹ Vgl: Stationäre Hebammenversorgung (2019) [Gutachten zeigt Situation der Hebammen in Kliniken](#)

sogar vier oder mehr Frauen gleichzeitig betreuen. Daher ist im Belegsystem die Verweildauer der Fachkräfte in der Geburtshilfe in der Regel auch deutlich besser.

Themenblock 2: Werden Beleghebammen kündigen? Hauptkritikpunkte am neuen Hebammenhilfvertrag

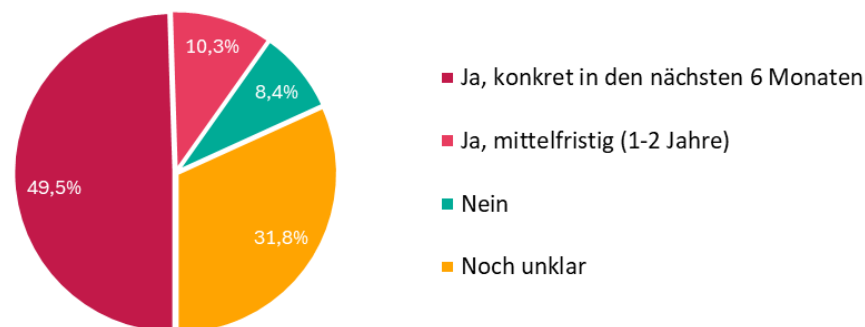
Werden Beleghebammen der Geburtshilfe verloren gehen?

Beleghebammen sind freiberuflich tätig. Sie bewerten ihre wirtschaftliche Situation individuell sowie im Belegteam – unabhängig von den sehr unterschiedlichen Modellrechnungen von GKV-Spitzenverband und DHV. Für die Versorgung in den Regionen ist am Ende entscheidend, ob diese Hebammen eine wirtschaftliche Zukunft für sich sehen und welche Konsequenzen sie sonst ziehen.

Eine aktuelle Umfrage (Mai/Juni 25) unter den Belegteams hat hierzu Zahlen geliefert:

Rund 70 % der befragten 154 Belegteams in Deutschland haben sich an der Umfrage beteiligt. 93 % dieser Teams geben an, dass der neue Hebammenhilfvertrag sich in Zukunft sehr negativ auf ihre Arbeit auswirkt. 100 % rechnen mit Einkommenseinbußen. Fast 49,5 % planen innerhalb der nächsten 6 Monate aus der Geburtshilfe auszusteigen, 99 % geben als Gründe dafür „wirtschaftlich nicht tragbar“ an, 57 % sehen keine Planungssicherheit gegeben. 81 % der Teams sehen derzeit keine tragfähige Alternative zum bestehenden Belegsystem.

Planen Kolleginnen konkret, aus der Geburtshilfe auszusteigen?
(107 Antworten)



Diese Zahlen zeigen deutlich, dass es unabhängig vom Streit welche Berechnungsmodelle zutreffen, eine **unmittelbare Lösung und vertrauensbildende Maßnahme** für die Belegteams geben muss, um eine Kündigungswelle abzuwenden.

Wirtschaftlichkeitsrechnung: es drohen in der Praxis Verdiensteinbußen von bis zu 30 %

Die umfangreiche Datenbasis der beiden größten Abrechnungsdienstleister für Beleghebammen zeigt deutlich, dass nach Anwendung der neuen Vergütungsregeln je nach Team den einzelnen Hebammen Verdiensteinbußen von 15-30 % drohen. Diese Ergebnisse werden durch die Datenerhebung des Deutschen Hebammenverbands in den Beleghebammenteams bestätigt.

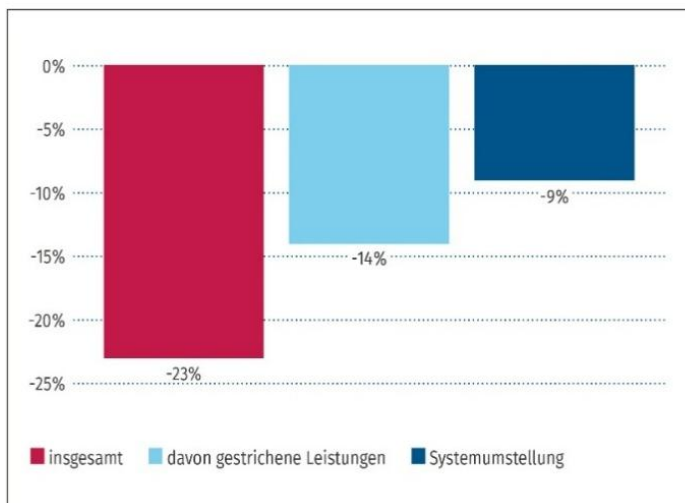
Auf Grundlage dieser Realdaten kann die vom GKV-Spitzenverband vorgelegte Modellrechnung für drei angenommene Einzelteams, bei denen angebliche Einkommenssteigerungen möglich seien, nicht nachvollzogen werden. Es liegt nahe, dass bei diesen Modellrechnungen entscheidende Fakten aus der Praxis nicht berücksichtigt wurden:

1. die viel zu **starre Definition der 1:1-Betreuung ist nicht praxistauglich** und kann voraussichtlich nur in knapp 10 % der Fälle greifen.
2. die **Mischkalkulation von abrechnungsfreien Zeiten und Abrechnungszeiten funktioniert dadurch nicht mehr**, da nur noch 80 % der Gebühren für die erste und 30 % für die zweite oder dritte betreute Frau abgerechnet werden können (Sanktionierung 1:2-Betreuung).

3. die festgesetzte Erhöhung der **Stundenvergütung** liegt, nach mehr als 8 Jahren ohne Gebührenerhöhung, weit unterhalb der Grundlohnsummensteigerung.
4. im neuen System können Beleghebammen die **ambulanten Leistungen der Notfallversorgung nicht mehr abrechnen**.

Auf Grundlage der Abrechnungsdaten der vergangenen zwei Jahre sind folgende Einbußen zu erwarten:

Durchschnittliche Veränderung der Vergütung einer Beleghebamme ab dem 01.11.2025



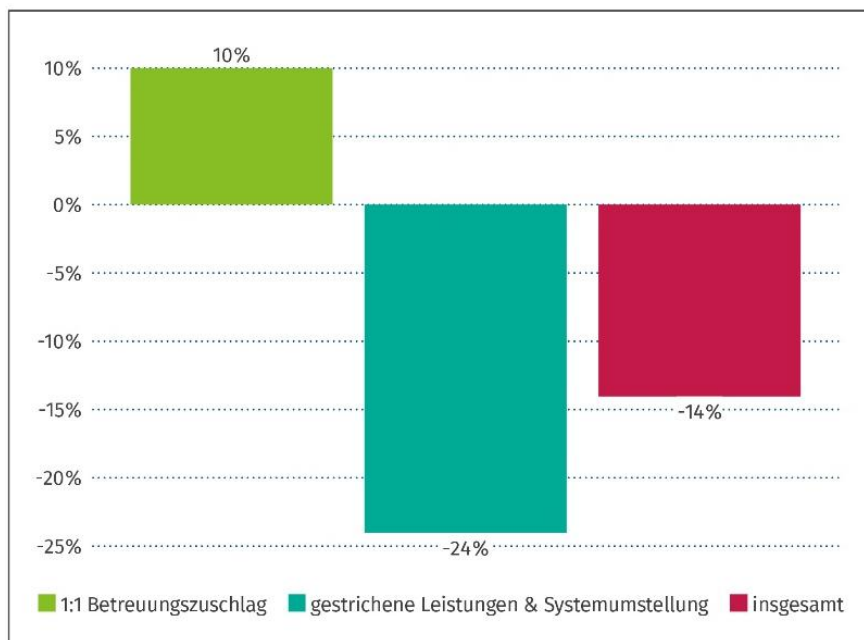
Gestrichene Leistungen, wie:

- Pauschalen für CTG
- Erstuntersuchung des Neugeborenen
- Entnahme von Körpermaterial
- Naht
- u.v.m.

Systemumstellung, durch:

- Wechsel von Pauschalen auf zeitliche Taktung.
- Wechsel der Abrechnungsgrundlage von angefangene 30 Minuten auf abgeschlossene fünf Minuten.
- Absenkung des Vergütungsniveaus auf 80 % bzw. 30 % bei einer zweiten und dritten Frau der freiberuflichen Hebammenvergütung außerhalb des Krankenhauses.
- Absenkung des Nachtzuschlags von 20 % auf 17 % und Kürzung der Nacht von 12 Stunden auf 9 Stunden.

Durchschnittliche Veränderung der Vergütung einer Beleghebamme bei angenommenem 100 % 1:1-Betreuungszuschlag²



Auch hier ist deutlich erkennbar, dass die **Systemumstellung Verluste** für die Beleghebammen bedingt, die weitaus größer sind als durch den Bonus für die 1:1-Betreuung ausgeglichen werden könnte.

² Vergleichszeitraum vom 1.5.2025 bis 31.10.2025

Themenblock 3: Wie kann das Problem gelöst werden?

Belastbares Versorgungsnetz für Mutter und Kind durch den Erhalt des Belegsystems sichern

Oberstes Ziel muss sein, die Versorgung der Frauen und Familien mit Geburtshilfe und Notfallversorgung auch nach dem 01.11.2025 sicherzustellen. Das geht nur durch Erhalt des Beleghebammen-systems. Dafür brauchen wir eine Lösung noch vor der politischen Sommerpause, spätestens zum 31. Juli, um zu verhindern, dass einzelne Hebammen oder ganze Hebammenteams ihre Verträge mit den Krankenhäusern kündigen. Dies kann nicht mehr mit langwierigen Verfahren ohne klaren Ausgang erreicht werden.

Das bedeutet:

- Die von der Schiedsstelle geplante AG der Verhandlungspartner zur retrospektiven Evaluation repräsentativer Abrechnungsdaten ist keine Lösung. Bis diese Daten vorliegen, sind die Belegteams aufgelöst. Ebenso ist die Zusammensetzung dieselbe, wie in den Vertragsverhandlungen.
- Der juristische Weg der Klage durch den DHV, sowohl das Angreifen des Schiedsspruchs als auch das Eilverfahren, dauern ebenfalls zu lange. Die Beleghebammen werden spätestens ab Juli die Verträge auflösen, um zum November aufhören zu können.
- **Es braucht daher unmittelbar ein klares, belastbares Signal von der Politik und den Vertragspartnern in Richtung der Berufsgruppe, um einen Dominoeffekt an Kündigungswellen aufzuhalten.**

Selbstverwaltung ist kein Selbstzweck. Um den Auftrag der Selbstverwaltung – die medizinische Versorgung der Bevölkerung – sicherzustellen, könnte eine Lösung wie folgt aussehen.

1. Vermittlung durch das BMG einer vertrauensbildenden Sofortmaßnahme, damit der Hebammenhilfekontrakt für den Bereich Beleghebammen zum 01.11.2025 nicht in Kraft tritt.
 - a. Dies könnte z.B. durch Aussetzung der Positionen im Vertrag bis zum Ergebnis einer **sofortigen Neuverhandlung** dieses Teilbereichs (mit fester Frist) geschehen.
 - b. **Garantierte Abrechnung der Belegleistungen nach altem Vertrag**, bis ein neuer Teilvertrag in Kraft tritt.
2. Sofortige unabhängige Überprüfung der Auswirkungen des Hebammenhilfekontrakts auf den Umsatz der Beleghebammen auf der Grundlage existierender Abrechnungsdaten, z. B. durch das BMG oder ein unabhängiges Institut.
3. **Neuverhandlung der Vertragsbestandteile, die das Belegsystem betreffen bis maximal 31.12.2025, rückwirkend zum 01.11.2025**

Für die Verbindlichkeit einer Lösung wäre die weitere Berichterstattung gegenüber dem Gesundheitsausschuss durch die Vertragspartner oder das BMG zum 31.10.2025 und dem 31.12.2025 gut.

*Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) ist ein Bundesverband und setzt sich aus 16 Landesverbänden zusammen. Mit rund 22.000 Mitgliedern ist der DHV der größte Hebammenberufsverband in Deutschland und vertritt die Interessen aller Hebammen. In ihm sind angestellte und freiberufliche Hebammen, Lehrer*innen für Hebammenwesen, Hebammenwissenschaftler*innen, Hebammen in den Frühen Hilfen, hebammengeleitete Einrichtungen sowie Hebammenstudierende*innen und Studierende vertreten. Über die berufliche Interessenvertretung hinaus ist eine gute medizinische und soziale Betreuung der Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit das zentrale Anliegen des Deutschen Hebammenverbandes. Als Mitglied in der European Midwives Association (EMA), im Network of European Midwifery Regulators (NEMIR) und in der International Confederation of Midwives (ICM) setzt sich der Verband auch auf europäischer und internationaler Ebene für die Stärkung der Hebammenarbeit sowie die Gesundheit von Frauen und ihren Familien ein.*

UMFRAGE

ZUKUNFT DER BELEGHEBAMMEN IN DEUTSCHLAND

AUSWIRKUNGEN DES NEUEN HEBAMMENHILFEVERTRAGS

Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit
Ausschussdrucksache 21(14)4.1 gel. VB zur 3. Sitzung am 25.06.2025 - Hebammen 23.06.2025

Der neue Hebammenhilfevertrag, beschlossen durch den Schiedsspruch vom 02. April 2025, stellt insbesondere Beleghebammen vor weitreichende Herausforderungen. Um belastbare Daten zur aktuellen Lage und zu den Auswirkungen auf die geburtshilfliche Versorgung zu erheben, wurde eine umfassende Befragung von Beleghebammen-Teams in gesamt Deutschland durchgeführt.

Ziel dieser Erhebung ist es, die konkreten Folgen des neuen Vertragswerks aufzuzeigen – etwa hinsichtlich Versorgungssicherheit, Arbeitsbedingungen, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Zukunftsperspektiven. Die Ergebnisse sollen eine faktenbasierte Grundlage für politischen Handlungsbedarf schaffen und die Dringlichkeit zielgerichteter Maßnahmen zur Sicherung der Beleggeburtshilfe unterstreichen.

Strukturelle Ausgangsdaten der Befragung

Zu Beginn der Erhebung wurden grundlegende Daten der Beleghebammen-Teams erfasst: Anzahl der tätigen Hebammen, durchschnittliches jährliches Geburtsaufkommen sowie die Versorgungsstufe der jeweiligen Klinik. Diese Basisinformationen ermöglichen eine erste Einordnung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, unter denen Beleghebammen arbeiten.

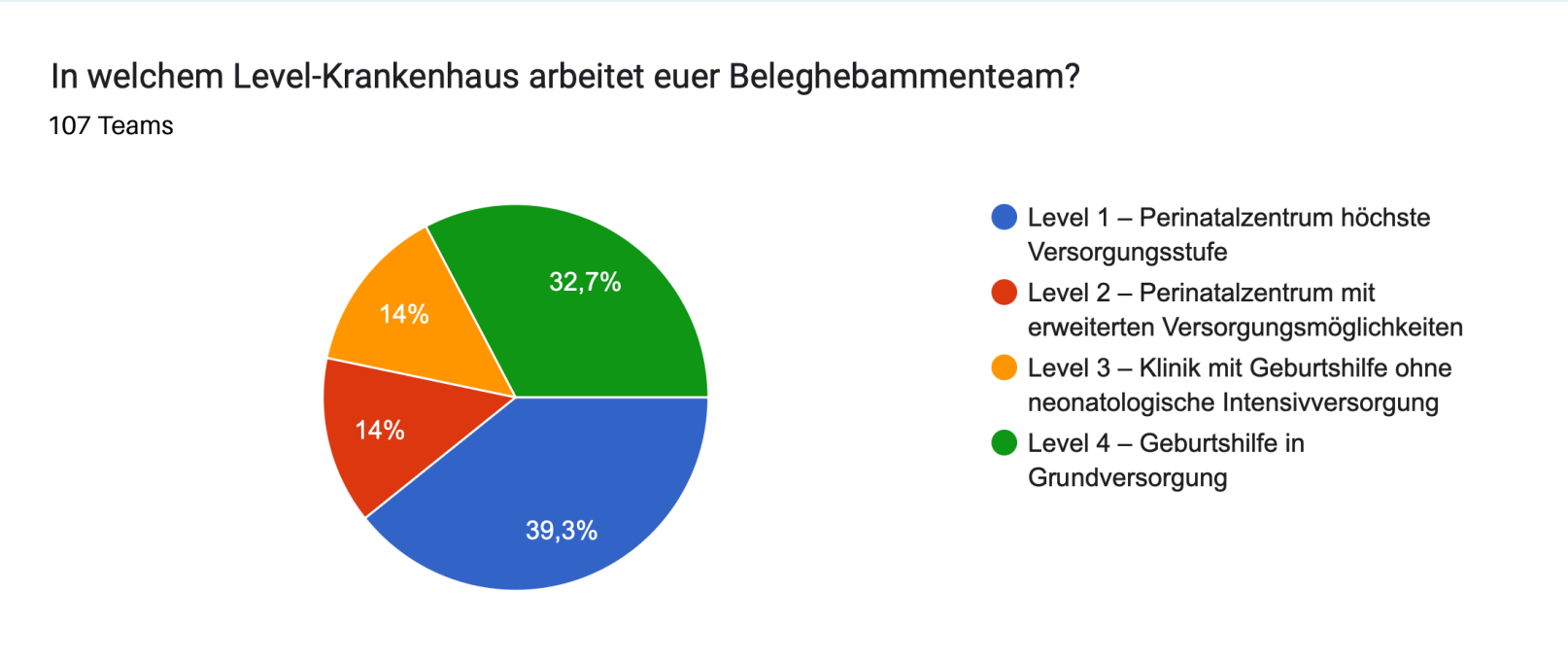
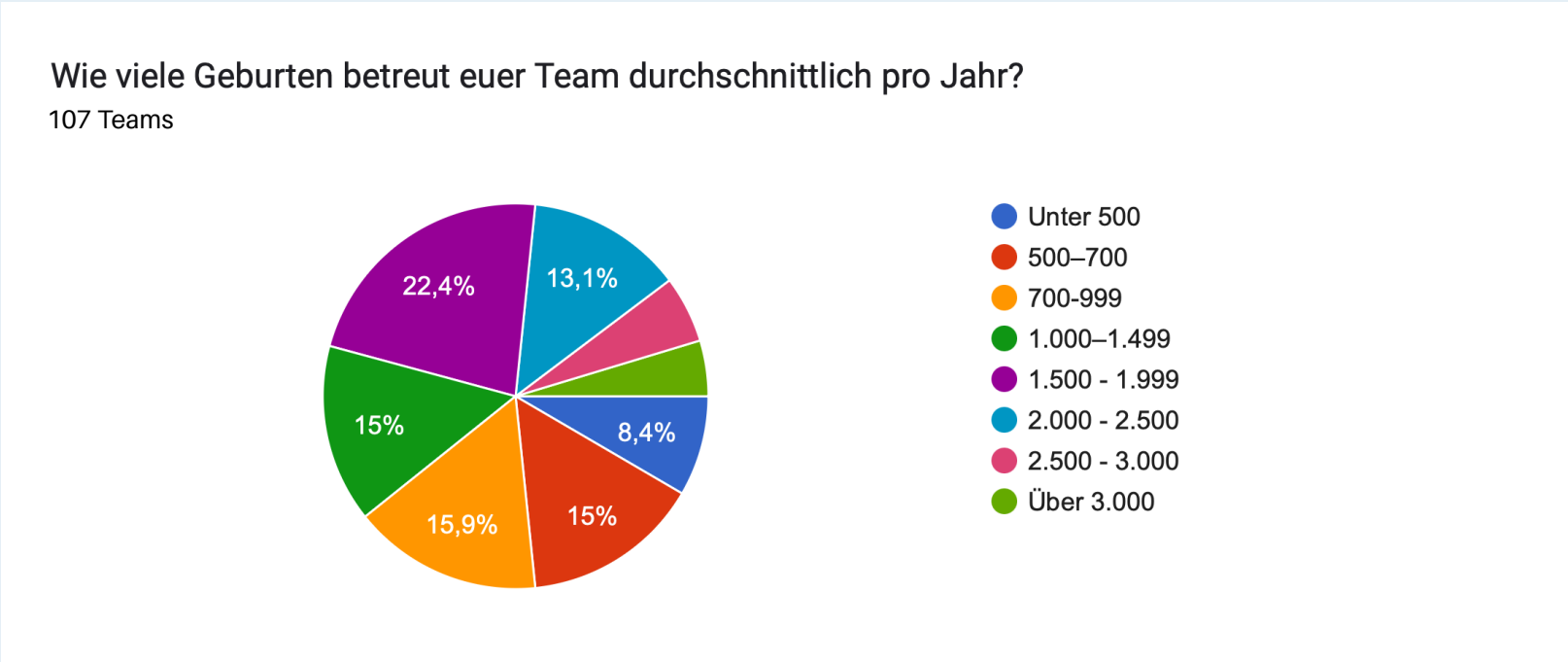
In Deutschland gibt es aktuell ca 150 aktive Beleghebammen-Teams. An der Umfrage haben 107 Teams aus dem gesamten Bundesland teilgenommen.

Insgesamt haben 107 Beleghebammen-Teams an der Umfrage teilgenommen – und die Spannbreite bei der Teamgröße ist groß:

- Die kleinsten Teams bestehen aus 7 Hebammen.
- Das größte Team zählt 43 Hebammen.

Am häufigsten vertreten sind mittelgroße Teams:

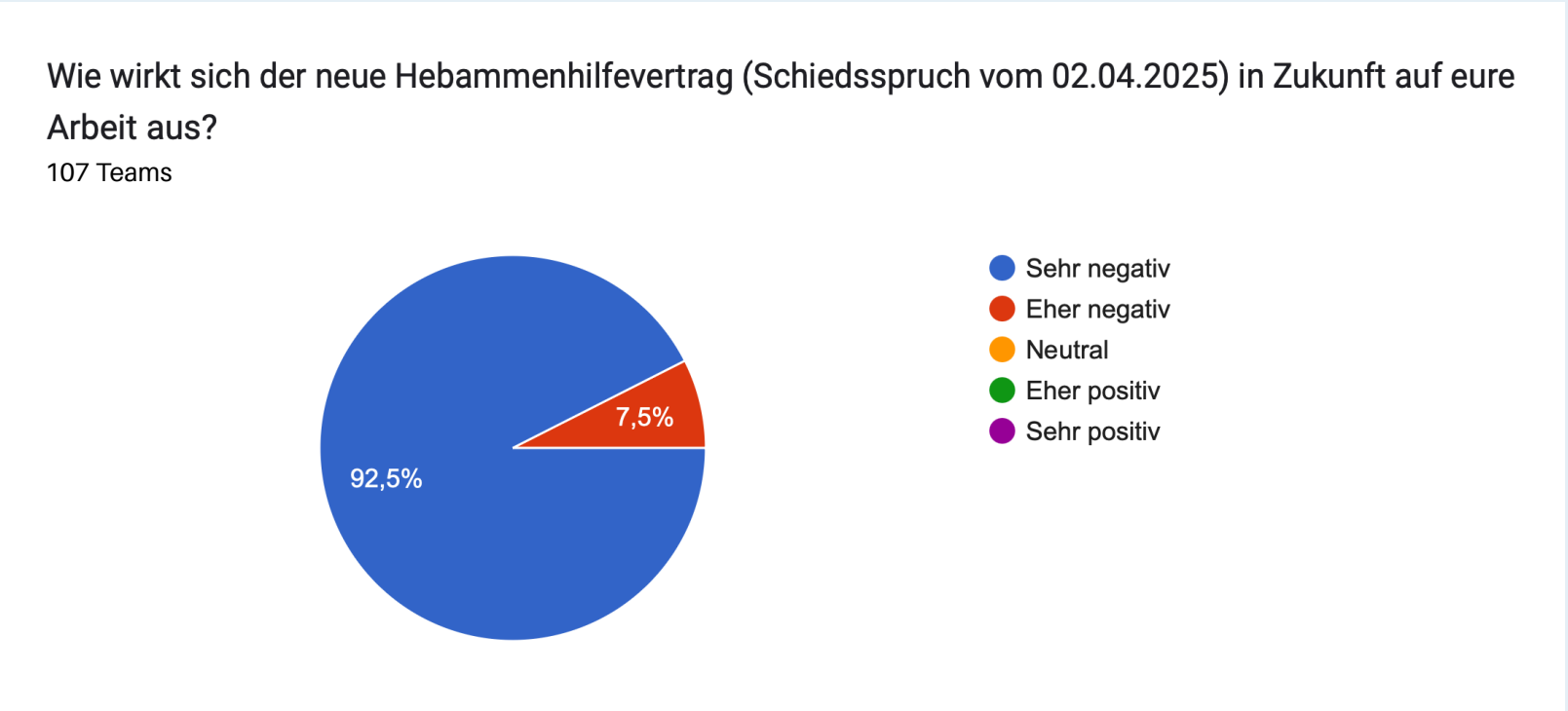
- Die meisten Teams liegen im Bereich von 11 bis 15 Hebammen. Und bei 19- 21 Hebammen
- Ebenfalls häufig: 30 Hebammen pro Team.



UMFRAGE

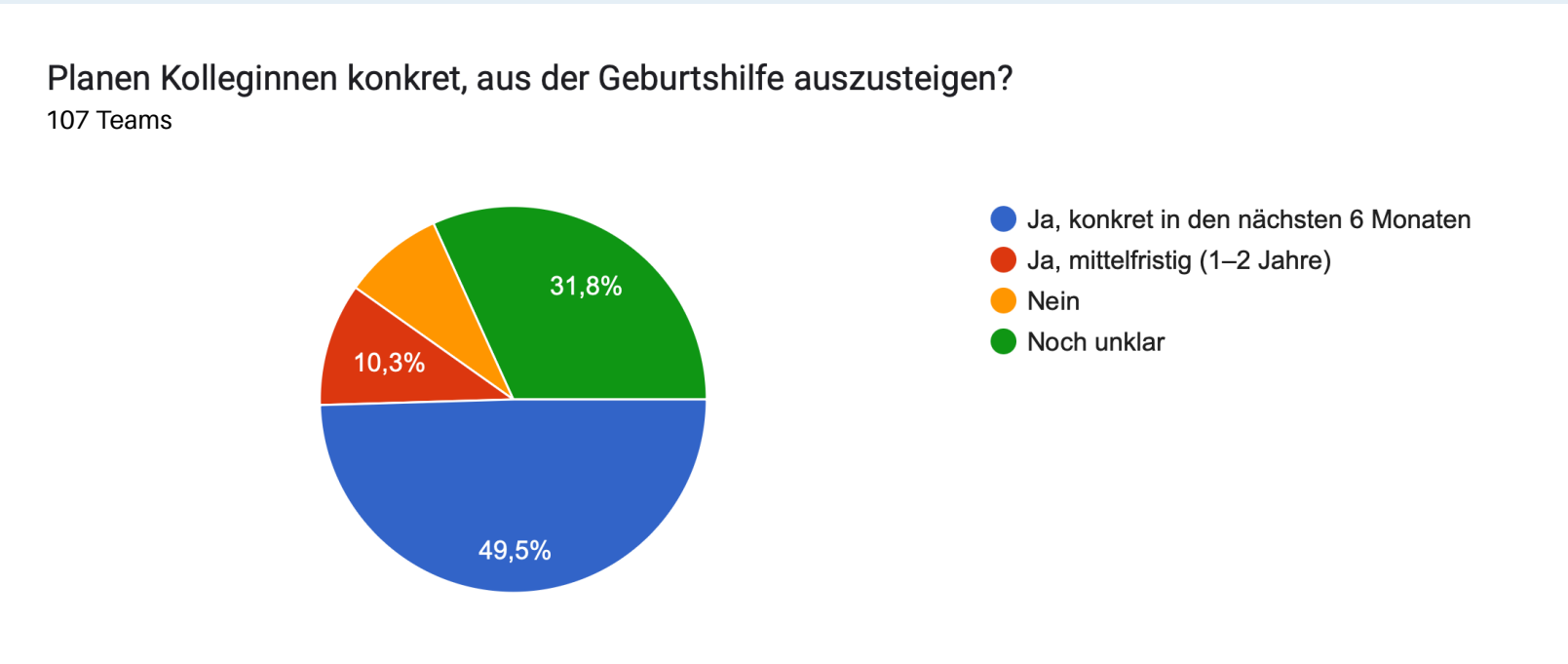
1. Auswirkungen des neuen Hebammenhilfevertrags auf die Arbeit der Teams

Alle Teams bewertet die Auswirkungen des neuen Vertrags auf ihre Arbeit als negativ, 92,5% sehr negativ und 7,5 % eher negativ, ein deutliches Signal für die weit verbreitete Unzufriedenheit mit den neuen Rahmenbedingungen.



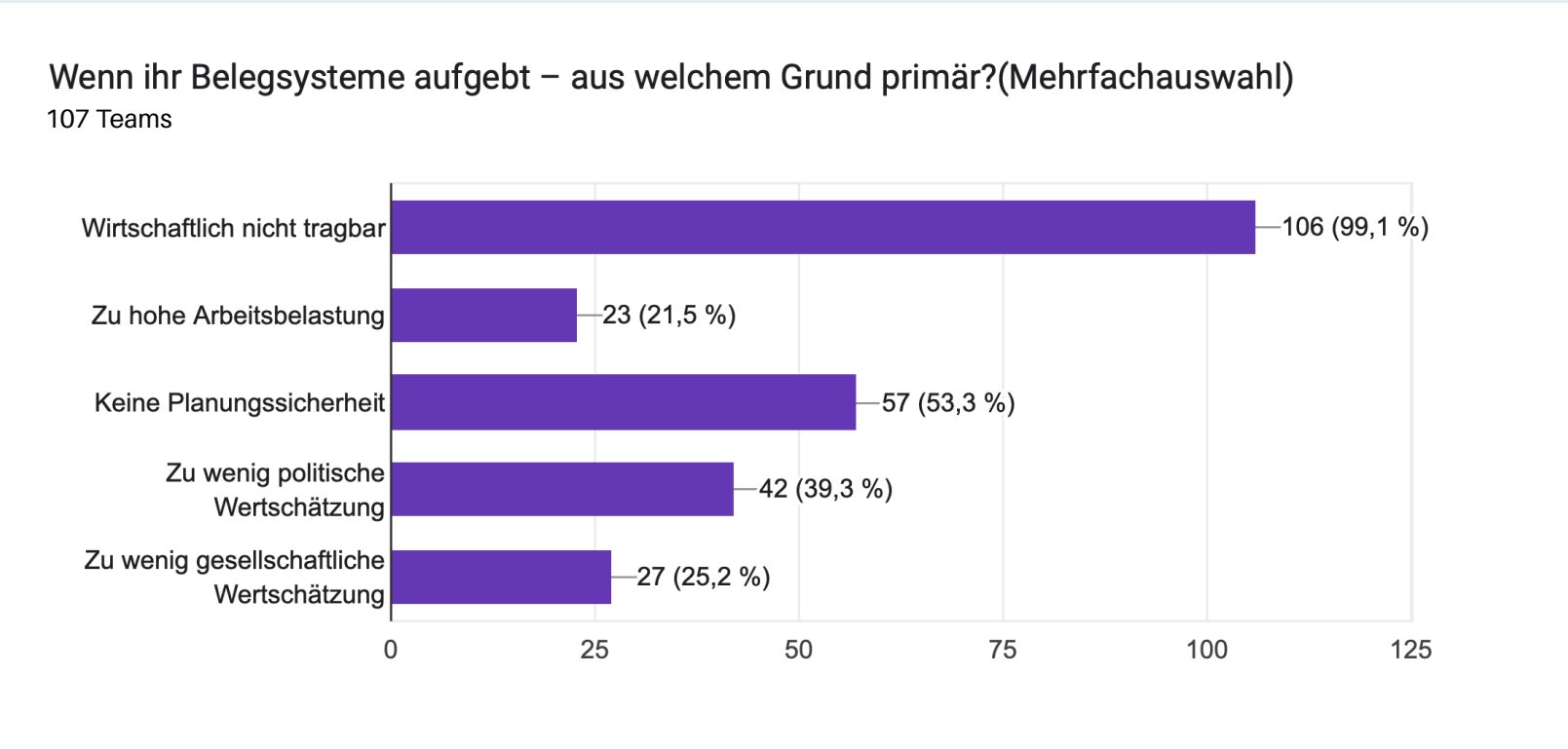
2. Pläne zum Ausstieg aus der Geburtshilfe

Ein erheblicher Teil der Beleghebammen plant bereits konkret oder mittelfristig den Ausstieg aus der Geburtshilfe. Nur ein kleiner Teil sieht derzeit keine Veränderung – viele Entscheidungen sind aber noch offen.



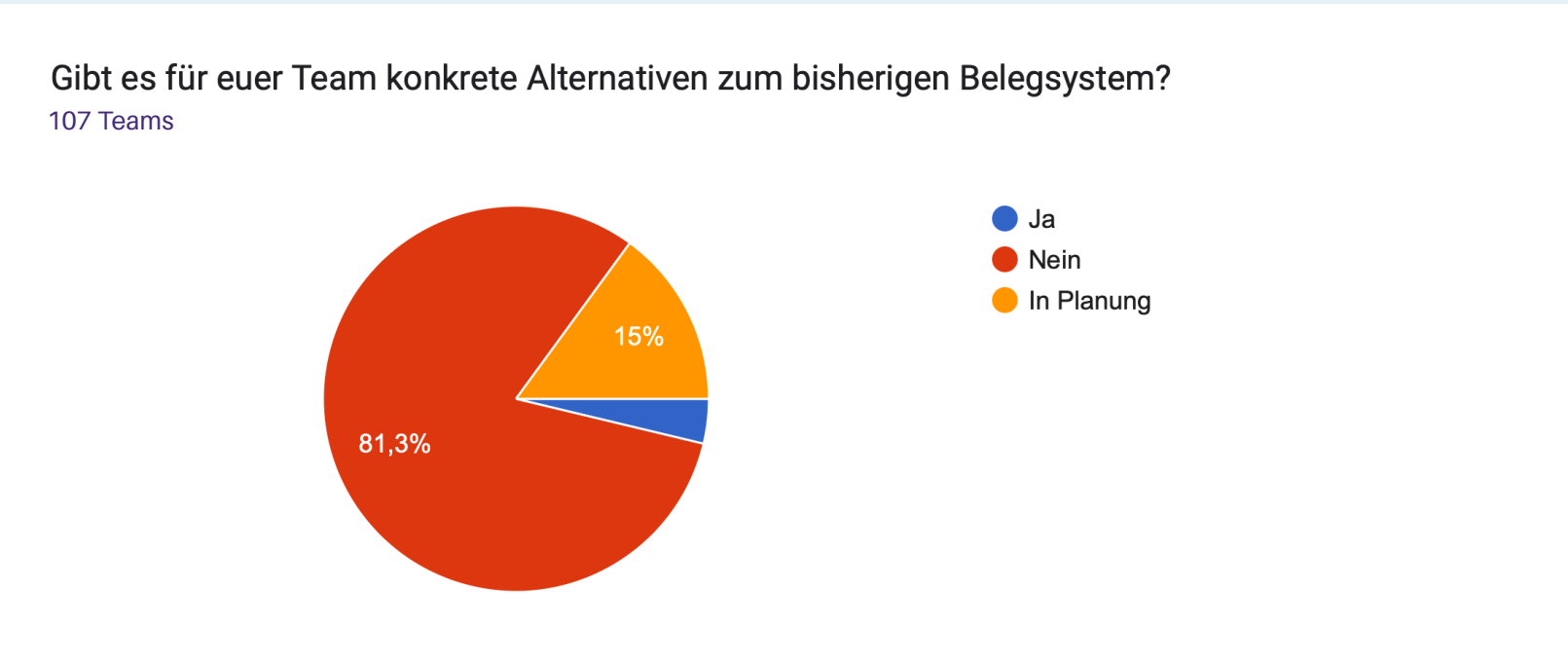
3. Gründe für die Aufgabe von Belegsystemen

Als Hauptgründe für den Rückzug aus dem Belegsysteem nennen die Teams wirtschaftliche Untragbarkeit und fehlende Planungssicherheit. Diese Faktoren ziehen sich durch nahezu alle Antworten.



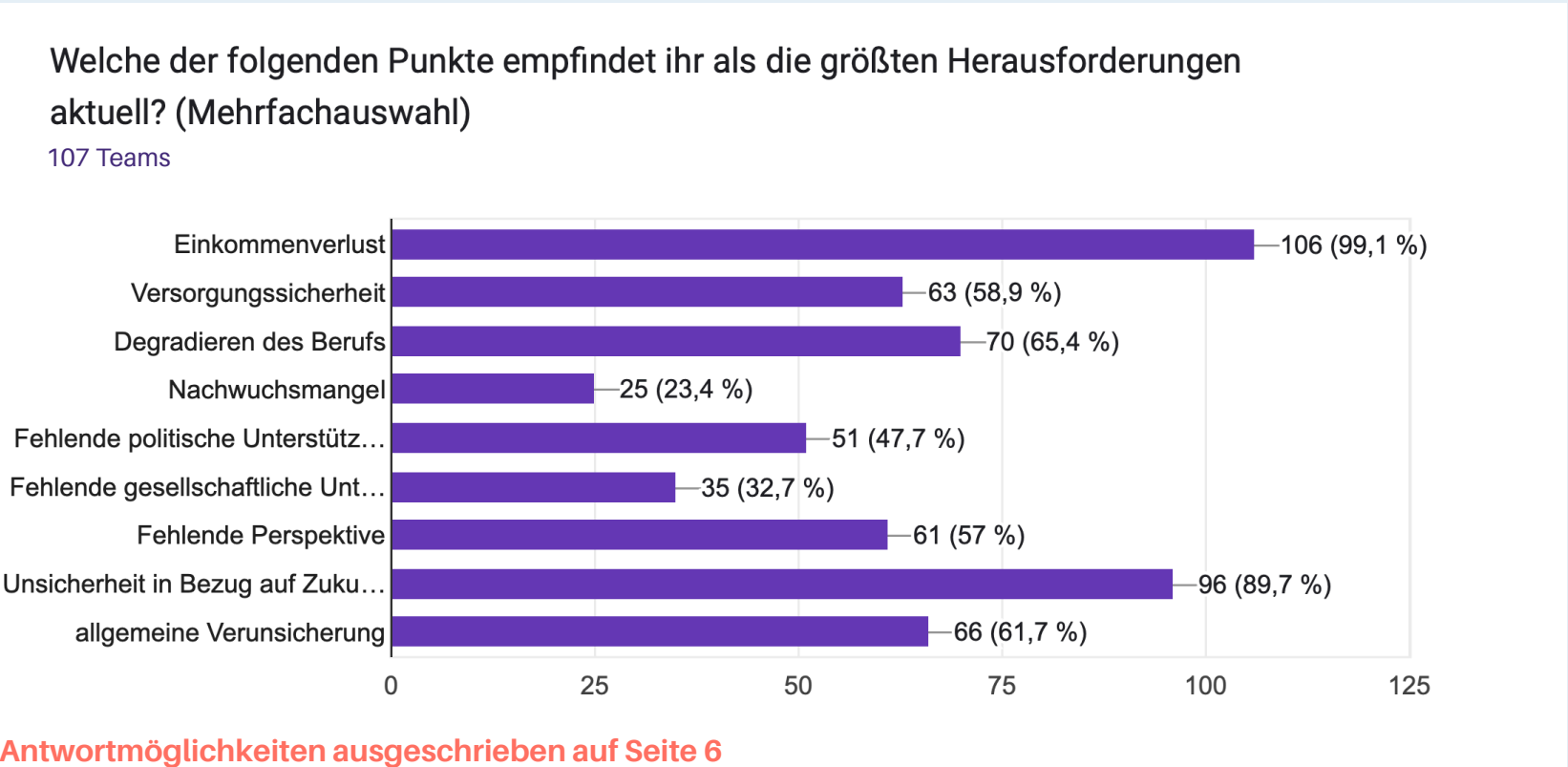
4. Alternativen zum Belegsysteem

Mehr als drei Viertel der Teams sehen derzeit keine tragfähige Alternative zum bestehenden Belegsysteem – ein deutliches Warnsignal für drohende Versorgungslücken.



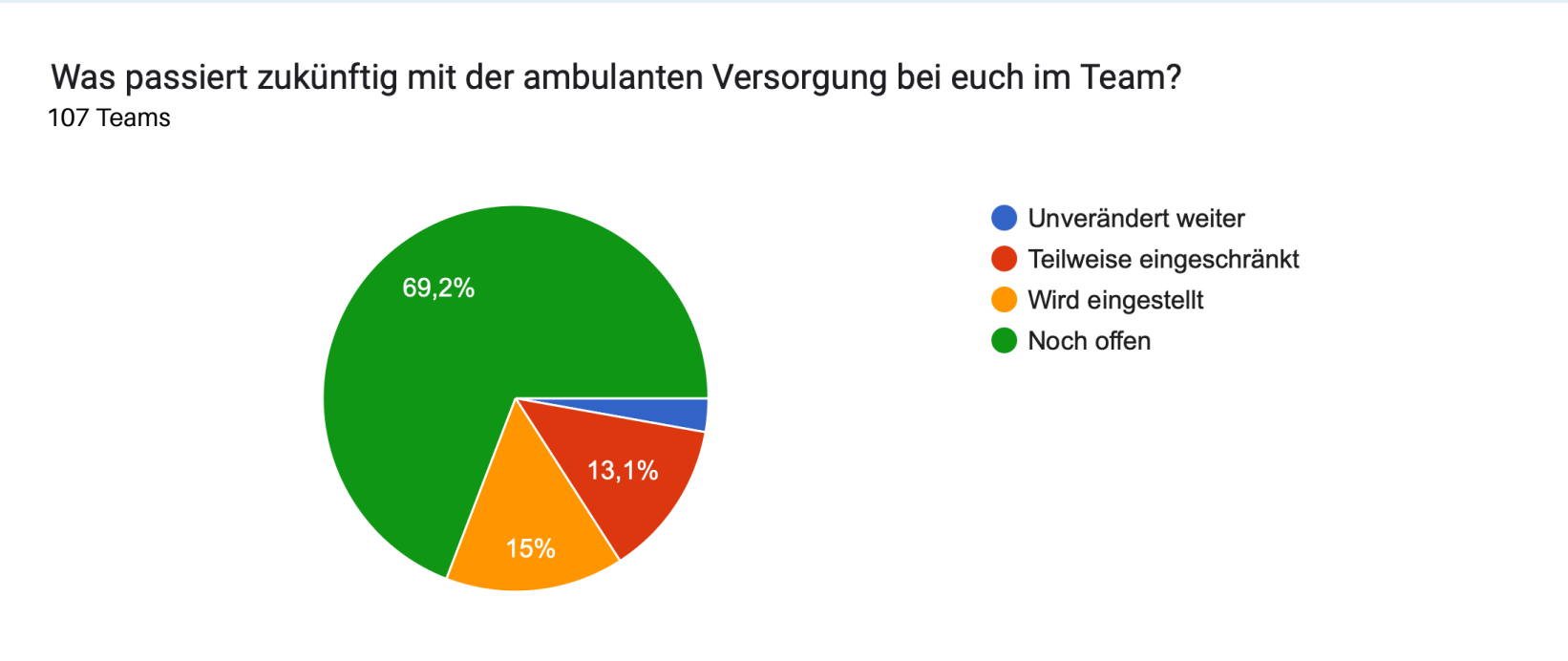
5. Größte Herausforderungen

Als größte Belastungen nennen die Teams die Einkommensverluste, den Mangel an politischer Unterstützung, wirtschaftlichen Druck und zunehmende Unsicherheit. Die Auswirkungen des neuen Vertrags verschärfen bestehende Probleme zusätzlich.



6. Zukunft der ambulanten Versorgung

Ein Großteil der Teams gibt an, dass die ambulante Versorgung künftig noch offen ist, 13,6 % gibt an sie zukünftig einschränken zu müssen. Ein Team geht davon aus, diese unter den neuen Bedingungen vollständig aufrechterhalten zu können.



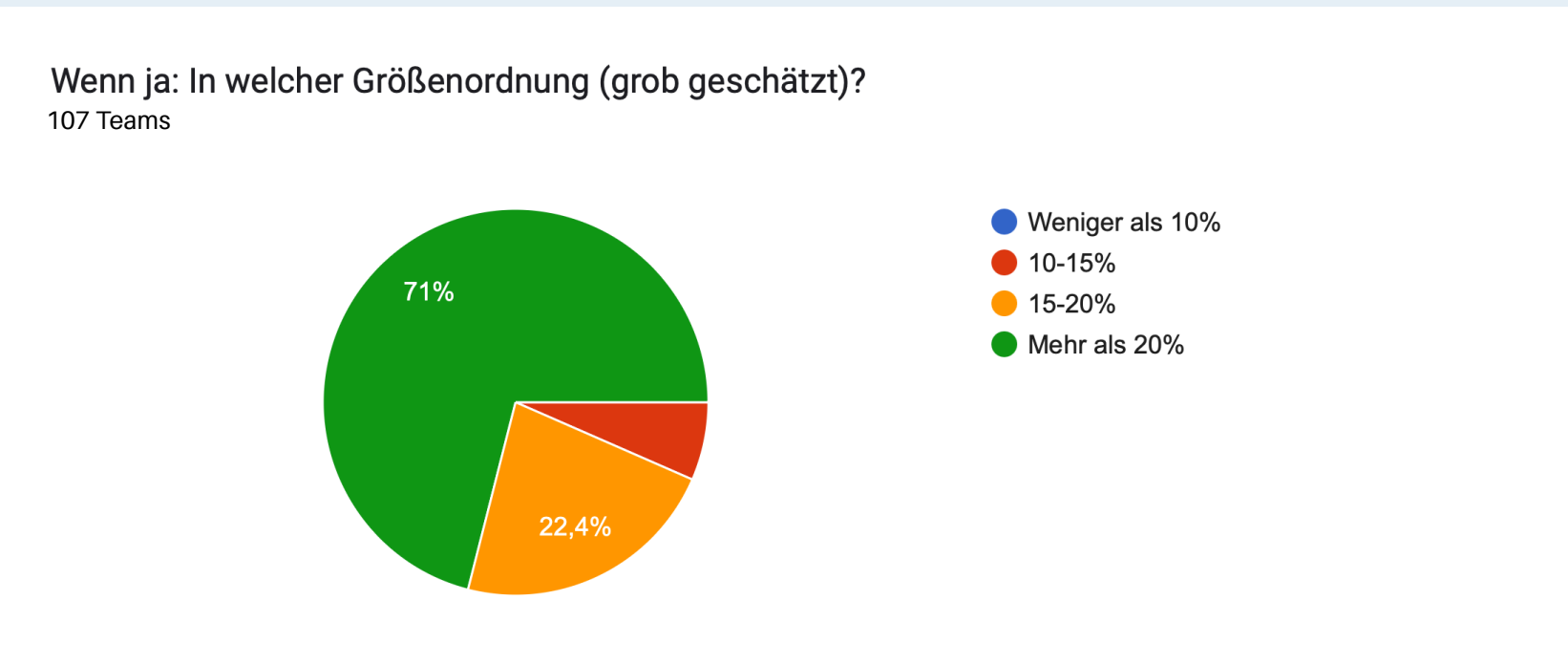
7. Erwartete Einkommensverluste

Alle befragten Teams rechnen mit Einkommenseinbußen infolge des neuen Vertrags. Die finanzielle Tragfähigkeit des Belegsystems ist damit grundsätzlich in Frage gestellt.



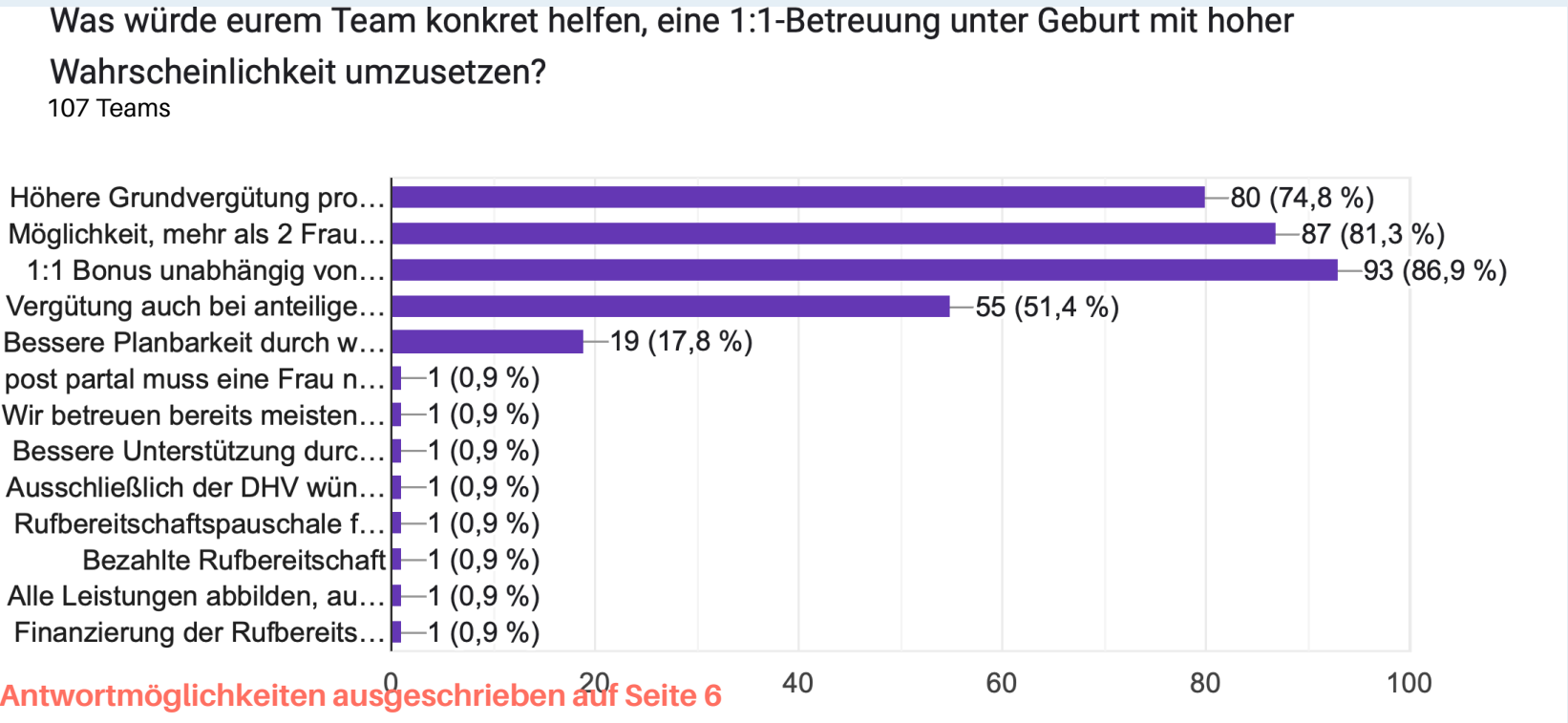
8. Geschätzte Höhe der Einkommensverluste

Alle Teams erwarten mindestens 10% Einkommensverluste, drei Viertel mehr als 20%, mit entsprechenden Konsequenzen für die Zukunftsfähigkeit.



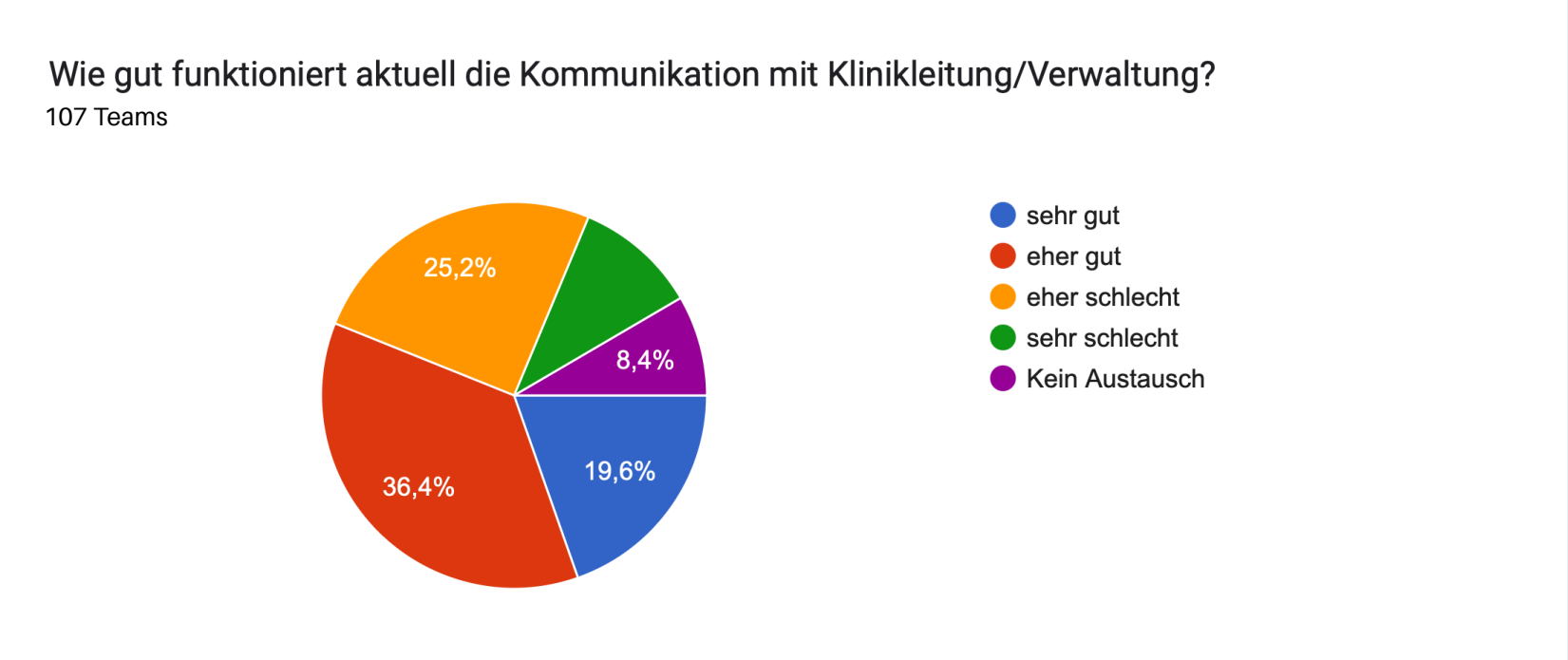
9. Voraussetzungen für eine 1:1-Betreuung unter Geburt

Die Umsetzung einer verlässlichen 1:1-Betreuung ist unter den aktuellen Bedingungen kaum machbar. Die häufigsten Forderungen sind: höhere Grundvergütung, bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten und der Wegfall der starren Bonusregelung (2h vor und 2h nach Geburt, ohne Schichtwechsel etc.)



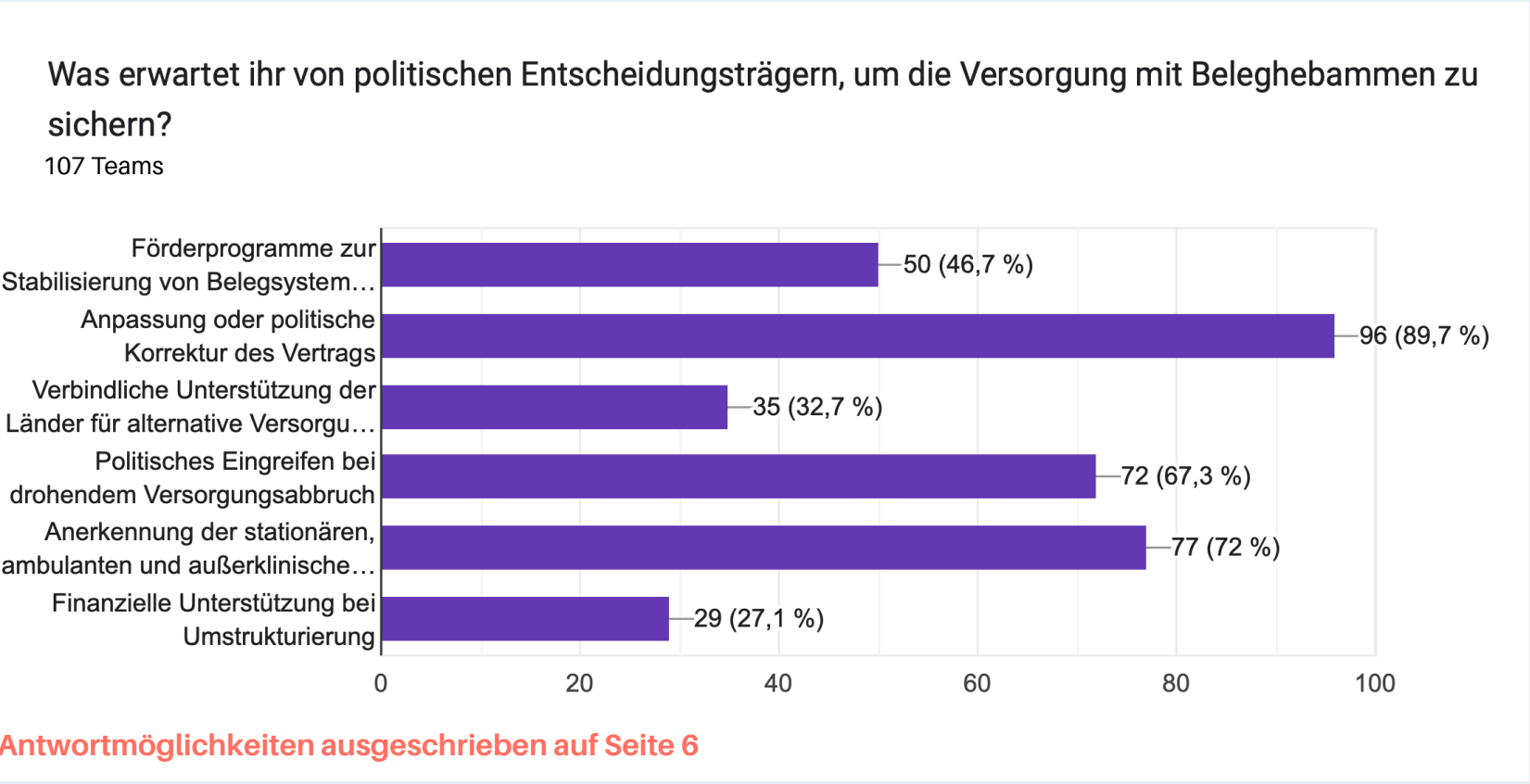
10. Kommunikation mit Klinikleitungen und Verwaltung

Die Einschätzungen zur Zusammenarbeit mit Klinikleitungen sind gemischt: Während 19,6% die Kommunikation als sehr gut und 36,4% als eher gut bewerten, berichten 10,3% von sehr schlechten, 25,2% von eher schlechten Erfahrungen und 8,4% von keinem Austausch. Trotz positiver Rückmeldungen bleibt die Zusammenarbeit für mehr als ein Drittel der Teams problematisch.



11. Erwartungen an die Politik

Die Erwartungen an politische Entscheidungsträger sind eindeutig: bessere Vergütung, rechtliche Absicherung, Sicherung ambulanter Leistungen und strukturelle Förderprogramme. Ohne konkretes politisches Eingreifen sehen viele Teams keine Perspektive für die Beleggeburthilfe.



Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ein klares und alarmierendes Bild: Der neue Hebammenhilfevertrag gefährdet die Arbeitssituation von Beleghebammen massiv – unabhängig von Teamgröße, Klinikstruktur oder Versorgungsstufe. Es kommt zu Einkommenseinbußen, Arbeitsüberlastung, eingeschränkter ambulanter Versorgung und dem drohenden Rückzug vieler Teams aus der Geburtshilfe. Trotz hoher fachlicher Kompetenz und großem Engagement stehen viele Teams vor dem strukturellen Aus. Die Bereitschaft, unter den aktuellen Rahmenbedingungen weiterzuarbeiten, sinkt deutlich – nicht, weil der Beruf an Bedeutung verloren hätte, sondern weil die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht mehr tragbar sind. Die freiberufliche Tätigkeit bietet akademisierten Kolleginnen keine Perspektive – ein Nachwuchsproblem besteht trotz ausreichend Absolventinnen. Um die geburtshilfliche Versorgung langfristig zu sichern, braucht es jetzt gezielte politische Maßnahmen: bessere Vergütung, verlässliche Rahmenbedingungen, Absicherung ambulanter Leistungen und klare gesetzliche Grundlagen für die 1:1-Betreuung. Ohne ein rasches Umsteuern droht dem Belegsyste

Fußnote - Ergänzende Lesefassung zu den Punkten 3, 5, 9 und 11:

Punkt 3 - Gründe für die Aufgabe von Belegschaften (Mehrfachauswahl):

- Wirtschaftlich nicht tragbar
- Zu hohe Arbeitsbelastung
- Keine Planungssicherheit
- Zu wenig politische Wertschätzung
- Zu wenig gesellschaftliche Wertschätzung

Punkt 5 - Welche der folgenden Punkte empfindet ihr als die größten Herausforderungen aktuell? (Mehrfachauswahl):

- Einkommenverlust
- Versorgungssicherheit
- Degradieren des Berufs
- Nachwuchsmangel
- Fehlende politische Unterstützung
- Fehlende gesellschaftliche Unterstützung
- Fehlende Perspektive
- Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft
- Allgemeine Verunsicherung

Punkt 9 - Was würde eurem Team konkret helfen, eine 1:1-Betreuung unter Geburt mit hoher Wahrscheinlichkeit umzusetzen?

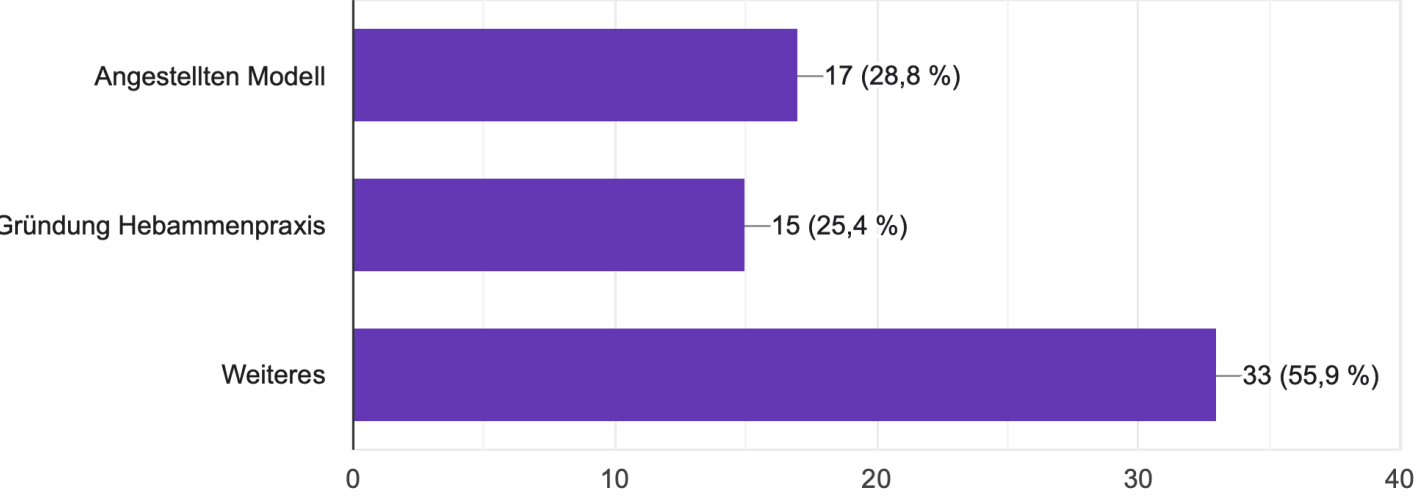
- Höhere Grundvergütung pro Geburt
- Möglichkeit, mehr als zwei Frauen gleichzeitig zu betreuen (z. B. bei geringer Auslastung oder in der Anfangsphase)
- 1:1-Bonus unabhängig von Schichtwechseln oder Geburtszeitpunkt
- Vergütung auch bei anteiliger 1:1-Betreuung (z. B. 50 %)
- Bessere Planbarkeit durch weniger Ambulanz- oder Stationsarbeit
- Sonstiges (Freitextantworten)

Punkt 11 - Politische Erwartungen zur Sicherung der Beleggeburthilfe (Mehrfachauswahl):

- Förderprogramme zur Stabilisierung von Belegschaften
- Anpassung oder politische Korrektur des Vertrags
- Verbindliche Unterstützung der Länder für alternative Versorgungsstrukturen
- Politisches Eingreifen bei drohendem Versorgungsabbruch
- Anerkennung der stationären, ambulanten und außerklinischen Leistungen
- Finanzielle Unterstützung bei Umstrukturierung

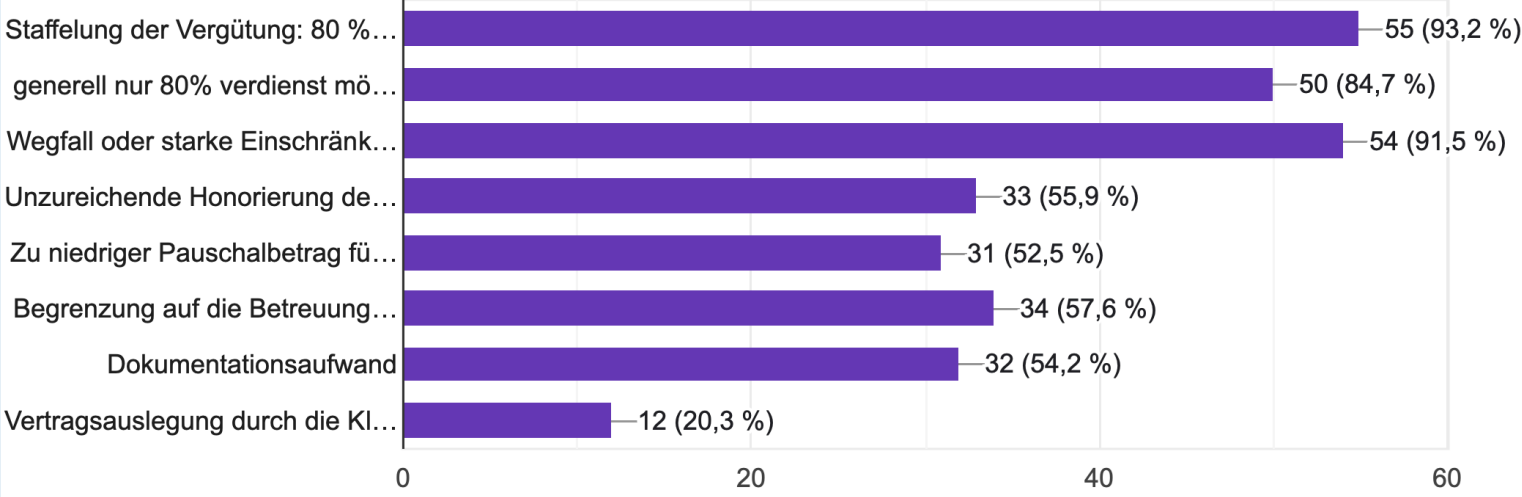
Falls ja: Welche Alternative verfolgt ihr? (Mehrfachauswahl)

59 Antworten



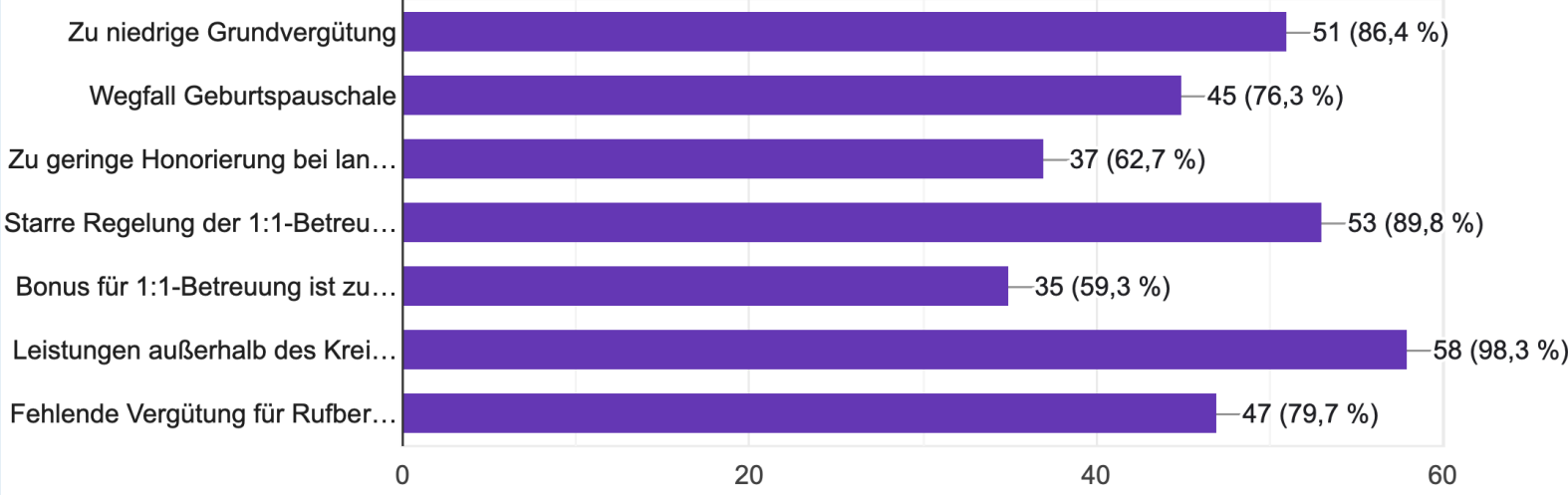
Welche der folgenden Punkte stellt für euch die größte Herausforderung im neuen Hebammenhilfevertrag dar?(Mehrfachauswahl)

59 Antworten



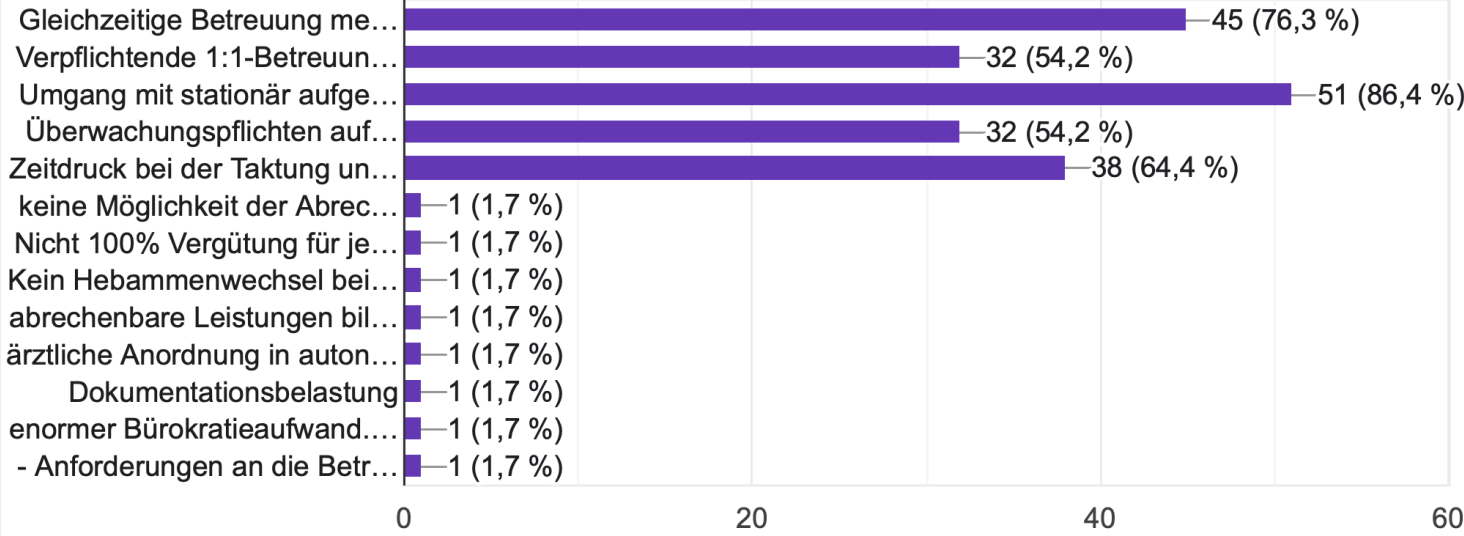
Welche Aspekte der aktuellen Vergütung im neuen Vertrag empfindet ihr als besonders problematisch?(Mehrfachauswahl)

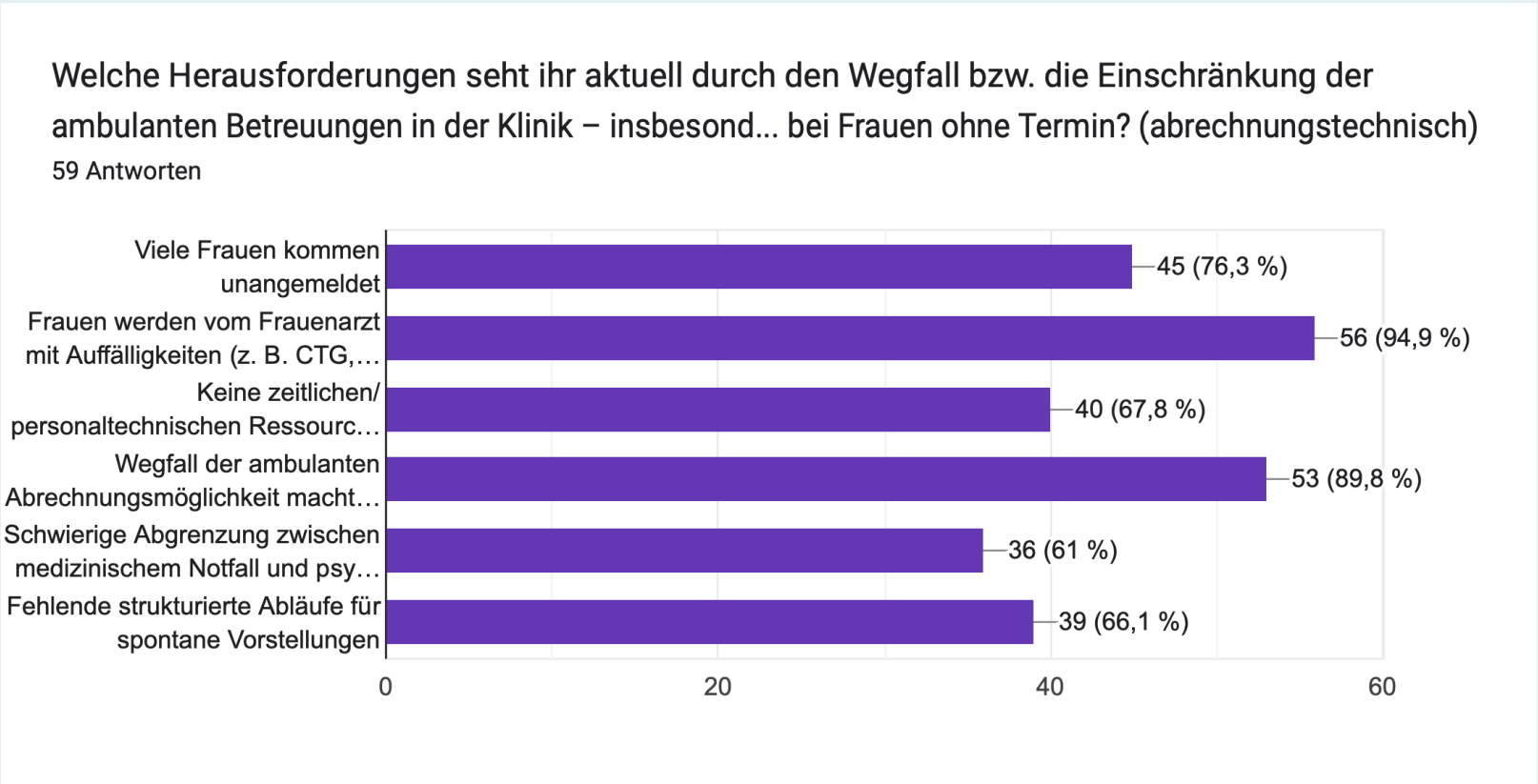
59 Antworten



Was ist aus eurer Sicht das größte Problem im stationären Setting nach neuem Vertrag?

59 Antworten





Umfrage.Zukunft der Beleghebammen- Auswirkungen des neuen Hebammenhilfevertrags

Eine Umfrage des Hebammenverband Baden Württemberg

[Sign in to Google](#) to save your progress. [Learn more](#)

* Indicates required question

zu welchem Beleghebammen Team gehört ihr (wird später anonymisiert)

Your answer

<https://forms.gle/rGmqZzeZnJiA2nEJA>

Stellungnahme des NWGH für den Gesundheitsausschuss 25.06.2025 – „Fachgespräch Hebammenhilfevertrag“

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie diesem wichtigen Thema Ihre Aufmerksamkeit schenken und uns Sachverständige dazu anhören

Das Netzwerk der Geburtshäuser vertritt seit über 30 Jahren die Interessen der Geburtshäuser auch in den Vertragsverhandlungen des § 134 a SGB V.

Hebammenhilfevertrag und Gebührenordnung umfassen die ganze Bandbreite der Hebammenleistungen:

- Mit und ohne Geburtshilfe
- In der Klinik, **in Geburtshäusern** und im häuslichen Bereich
- Einzelhebammen, Hebammenteams

Und in allen denkbaren Kombinationen davon

Für jede dieser Konstellationen müssen sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Vergütung stimmen. Die Vertragspartner tragen gemeinsam die Verantwortung für ein funktionierendes Gesamtsystem.

Der gerade festgesetzte Hebammenhilfevertrag bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich, ein paar Beispiele:

- Es wurden neue Leistungspositionen eingeführt
- Wichtige Tätigkeiten, die Zeit brauchen, werden jetzt besser vergütet – was durch die vorherigen Pauschalen nicht möglich war
- Die außerklinische Geburtshilfe hat ein solides finanzielles Fundament bekommen
- In jedem Bereich wurde darauf geachtet, die 1:1 Betreuung zu honorieren und zu verstärken

Die Verhandlungen waren langwierig, auch weil der Vertrag strukturell völlig neu aufgesetzt wurde. Die größte Neuerung: die weitgehende Umstellung von Pauschalen auf eine zeitbasierte Abrechnung

Die Grundlage für eine Vergütungsordnung wurde von Netzwerk, DHV und BfHD gemeinsam erarbeitet. Dafür haben wir:

- ein Kalkulationsschema entwickelt, das sich an tariflichen Strukturen orientiert
- eine transparente Berechnung angemessener Stundenumsätze für freiberuflich tätigen Hebammen ermöglicht
- und berücksichtigt, dass Hebammen nicht nur eine hohe fachliche Verantwortung tragen, sondern auch ein unternehmerisches Risiko

Dieses Modell konnte die Vertragspartnerseite der Kassen überzeugen.

In der einberufenen Schiedsstelle unter Leitung von Brigitte Zypries konnten weitere Verbesserungen verhandelt werden,

Ein Vertrag mit so vielen neuen Stellschrauben bringt es zwangsläufig mit sich, dass nicht alle Wechselwirkungen im Vorfeld exakt absehbar sind. Das ist jedem Honorarverteilungssystem üblich. Die Befürchtungen von Einkommensverlusten ist verständlich. Umso wichtiger ist es, dass die Umsetzung des Vertrags genau beobachtet und geprüft wird.

Ein besonders komplexer Punkt war die Vergütung von Beleghebammenteams in Kliniken. wegen der Überschneidung von zwei **unterschiedlich strukturierten** und **finanzierten Systemen** (freiberufliche Beleghebammentätigkeit eingebettet in das Krankenhaussystem).

Erst gegen Ende der Verhandlungen lagen Abrechnungsdaten von Beleghebammenteams vor, auf deren Basis ebenfalls eine **Vergütungserhöhung** vereinbart wurde

Zur weiteren Absicherung haben die Vertragspartner in der Schiedsstelle einen zusätzlich Vertragsbestandteil eingebracht:

Und zwar eine paritätisch besetzte AG, diese soll:

- die Vertragsumsetzung begleiten
- Probleme aufgreifen
- und evtl. Fehlentwicklungen so zügig wie möglich korrigieren.

Sie tritt Anfang Juli zusammen und wenn die offenbar zunehmende Unsicherheit bei den Beleghebammenteams Kündigungswellen auslöst und dadurch die Versorgungssicherheit gefährdet ist, dann muss diese Arbeitsgruppe hier mit geeigneten Mitteln **und sehr schnell**, innerhalb der nächsten Wochen, für Sicherheit sorgen.

Die bisherigen Verhandlungen haben wir gezeigt, dass die Vertragspartner in der Lage sind, auf einer konstruktiven Basis entschlossen zu verhandeln.

25.06.2025

Dr. Christine Bruhn

Im Vorstand Netzwerk der Geburtshäuser e.V.

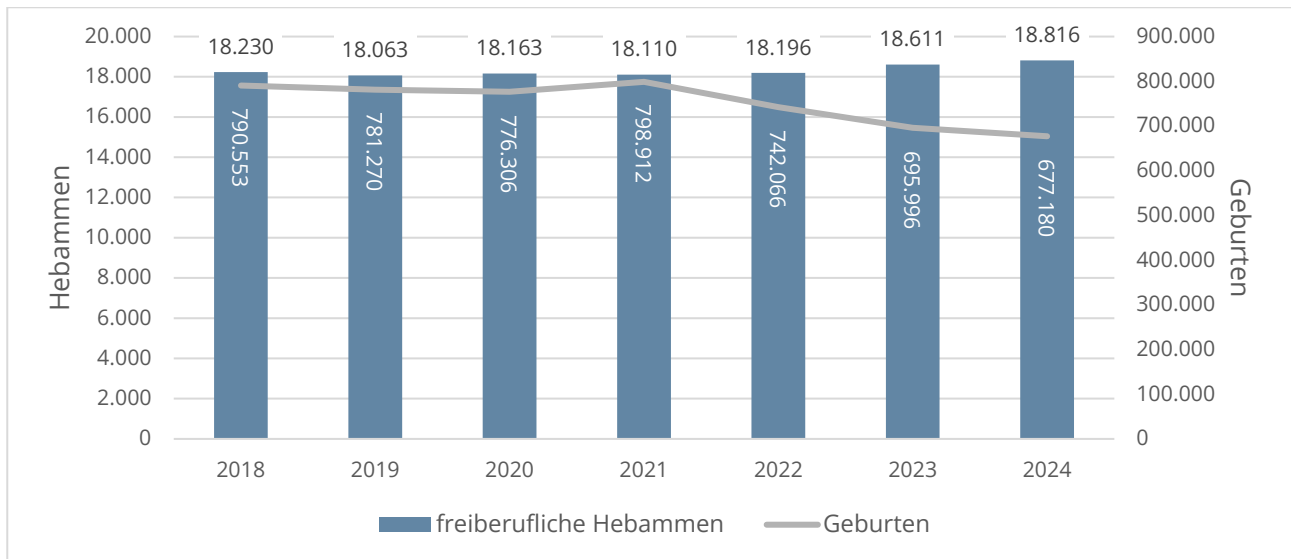


Deutscher Bundestag
Ausschuss f. Gesundheit

Ausschussdrucksache
21(14)7
gel. VB zur 3. Sitzung am
25.06.2025 - TOP 3 Hebammen
25.06.2025

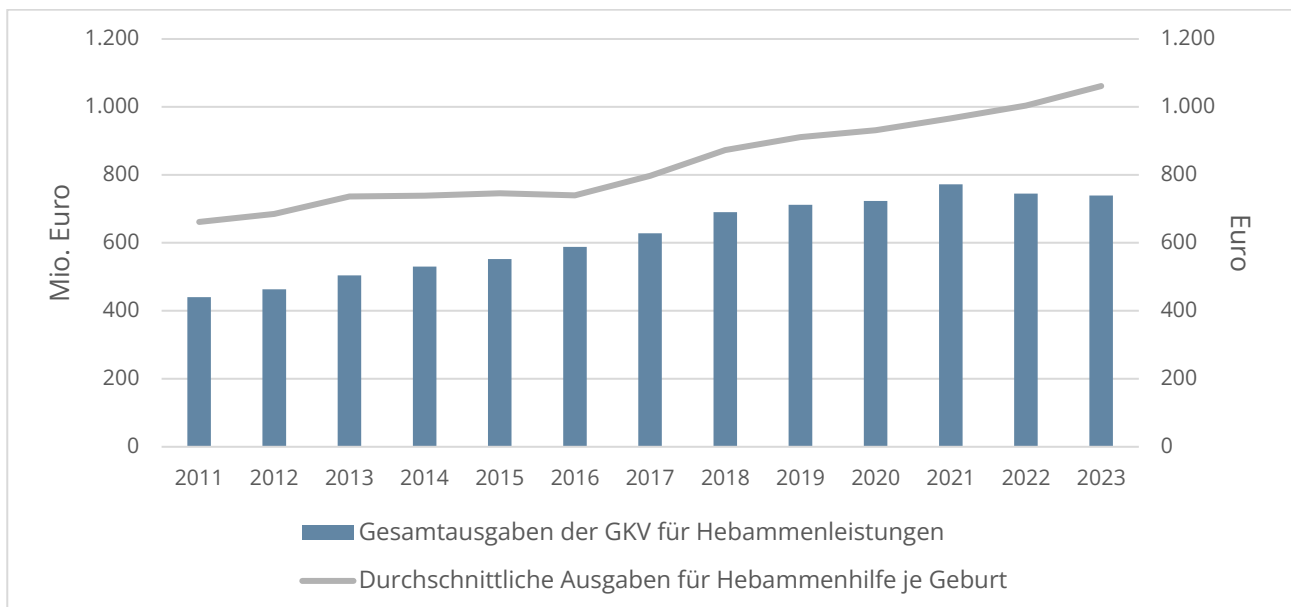
Kennzahlen zu freiberuflich tätigen Hebammen nach § 134a Absatz 1 SGB V

Freiberuflich tätige Hebammen und Anzahl der Geburten



Quelle: Vertragspartnerliste Hebammen und destatis

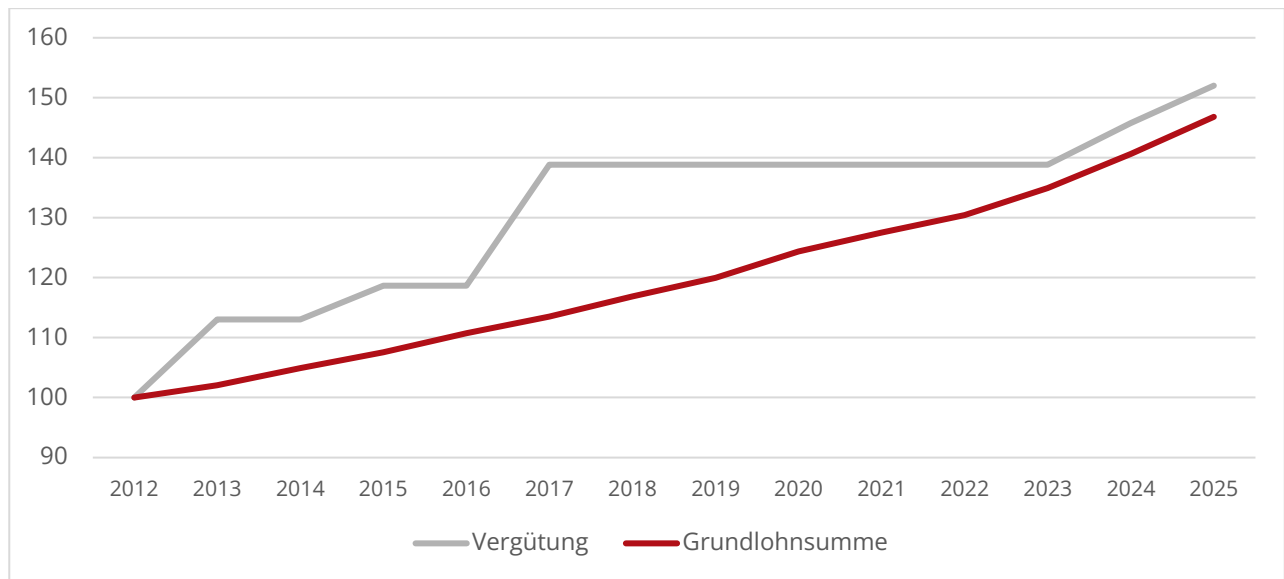
Gesamtausgaben und durchschnittliche Ausgaben je Geburt



Quelle: destatis und Amtliche Statistik KJ 1

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Entwicklung der Vergütung und der Grundlohnsumme (2012 = 100)



Quelle: Hebammenhilfevertrag und Bekanntmachungen des Bundesministeriums für Gesundheit

Vergütungsveränderung im neuen Hebammenhilfevertrag bei ausgewählten Leistungen

Leistung (je ohne Nachtzuschlag)	Dauer	Vergütung alt	Vergütung neu	Differenz
Aufsuchende Hilfeleistung bei Schwangerschaftsbeschwerden	45 Min.	41,40 Euro	55,71 Euro	+34,6 %
Geburtsvorbereitungskurs mit 8 Teilnehmerinnen	60 Min.	63,68 Euro	91,20 Euro	+43,2 %
Hilfe bei einer Hausgeburt	8 Std.	655,05 Euro	917,31 Euro	+39,9 %
Hilfe bei einer Geburtshausgeburt (ohne Betriebskostenpauschale)	8 Std.	526,38 Euro	804,94 Euro	+52,9 %
Hilfe bei einer Geburt als Dienst-Beleghebamme mit 1:1-Betreuung	8 Std.	331,20 Euro	579,19 Euro	+74,9 %
Hilfe bei zwei Geburten als Dienst-Beleghebamme mit 1:2-Betreuung	8 Std.	662,40 Euro	653,76 Euro	-1,3 %
Aufsuchende Hilfeleistung im Wochenbett	45 Min.	38,46 Euro	55,71 Euro	+44,9 %

Quelle: Hebammenhilfevertrag

Auswirkungen des neuen Hebammenhilfevertrages auf ein konkretes Beleghebammenteam

Anzahl Frauen	1	2	3	Umsatz
Bisher erbrachte Stunden/ Vergütung	149,5	140,0	19,5	23.682 €¹
Anteil der erbrachten Stunden	48,4 %	45,3 %	6,3 %	
Neue Vergütung pro Stunde Tag (Anteil 48 %)	68,09 €	81,71 €	103,99 €	
Neue Vergütung pro Stunde Nacht (Anteil 52 %)	79,69 €	95,60 €	121,67 €	
Durchschnittlich neue Vergütung	74,11 €	88,93 €	113,18 €	
Neue Vergütung insgesamt	11.079 €	12.450 €	2.207 €	25.737 €

Quelle: Abrechnungsdaten eines Beleghebammenteams

Einkommensvergleich verschiedener Berufsgruppen

	Arzt	Fachärztin	Hebamme	Beleghebamme
Grundlage	TV-Ärzte (3. Jahr)	TV-Ärzte (7. Jahr)	TVöD-P11 (Stufe 4) ²	§ 134a SGB V
Monatsbrutto	6.034 €	8.402 €	4.768 €	8.000 €
Sozialabgaben	1.243 €	1.457 €	1.027 €	1.141 €
Steuer	1.117 €	2.056 €	734 €	1.548 €
Monatsnetto	3.674 €	4.889 €	3.007 €	5.311 €

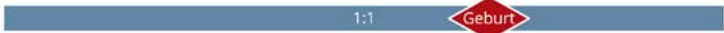
Quelle: TV-Ärzte (VKA) nach Marburger Bund, TVöD-P11, Hebammenhilfevertrag; Berechnung anhand www.brutto-netto-rechner.info und www.bmf-steuerrechner.de

In den Sozialabgaben der Beleghebamme sind noch keine Renten- oder Arbeitslosenversicherung enthalten. Bei der angestellten Hebamme entsprechen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmeranteil dafür ca. 1.000 Euro. Würde die Beleghebamme denselben Betrag für die Altersvorsorge und ihren Notgroschen zurücklegen, hätte sie ein verfügbares Einkommen von ca. 4.300 Euro pro Monat, mithin 1.300 Euro mehr als ihre angestellte Kollegin.

¹ Beinhaltet alle von den Beleghebammen abgerechneten Leistungen (z.B. CTG, Entnahme von Körpermateriale, U1-Untersuchung).

² In den Vertragsverhandlungen wurde für die Vergütungsberechnung die damalige Eingruppierung in P9, also vor dem jüngsten Tarifabschluss, zu Grunde gelegt.

Vergütung einer Beleghebamme anhand einer beispielhaften Arbeitswoche

	8.00 Uhr	10.00 Uhr	12.00 Uhr	14.00 Uhr	16.00 Uhr	bisher	neu
Montag						331,20 Euro	579,19 Euro
Dienstag						0 Euro	0 Euro
Mittwoch						703,80 Euro	676,08 Euro
Donnerstag						248,40 Euro	282,24 Euro
Freitag						455,40 Euro	468,00 Euro

Die Grafik stellt schematisch eine beispielhafte Arbeitswoche einer Beleghebamme mit insgesamt vier Geburtsbetreuungen dar:

Montag: Die Hebamme betreut durchgängig eine Versicherte. Das Kind kommt um 13.30 Uhr zur Welt. Für diese 1:1-Betreuung erhält die Hebamme einen Zuschlag für vier Stunden (zwei Betreuungsstunden vor und zwei Stunden nach der Geburt).

Dienstag: Es kommen keine Versicherten in den Kreißsaal. Die Hebamme kann in dieser Zeit zwar keine Leistungen abrechnen, die Zeit aber beispielsweise für Verwaltungstätigkeiten nutzen.

Mittwoch: Die Hebamme kümmert sich wechselweise um zwei Versicherte (d.h. eine Versicherte wird betreut, die andere im Nebenraum überwacht), von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr sogar um drei Versicherte. Für Geburten in 1:2- (oder 1:3-)Betreuung erfolgt kein Zuschlag.

Donnerstag: Erst um 12.00 Uhr kommt die erste Versicherte in den Kreißsaal, deren Betreuung die Hebamme übernimmt. Ab 14.00 Uhr wird eine zweite Versicherte überwacht.

Freitag: Die Hebamme übernimmt zu Arbeitsbeginn die wechselweise Betreuung von zuerst drei Versicherten, die nach und nach entlassen werden.

Je nach Dauer und Anzahl der betreuten Versicherten kann die Hebamme pro Tag unterschiedliche Summen mit den Krankenkassen abrechnen. In dieser beispielhaften 40-stündigen Arbeitswoche wird in vier Stunden (= 10 Prozent) eine zuschlagsfähige 1-1-Geburtenbetreuung durchgeführt, in weiteren 8 Stunden (= 20 Prozent) eine 1-1-Betreuung ohne Zuschlag. In 12 Stunden (= 30 Prozent) erfolgt eine 1:2-Betreuung. Weitere zwei Stunden (= 5 Prozent) entfallen auf 1:3-Betreuungen. In den restlichen 14 Stunden (= 35 Prozent) erbringt die Hebamme keine abrechenbaren Leistungen.

Insgesamt erzielt die Hebamme im Beispiel einen Umsatz in einer Arbeitswoche von 2.006 Euro (statt bisher 1.739 Euro³). Bei 20 Arbeitstagen pro Monat entspräche dies einer

Gesamtvergütung von 8.022 Euro. Würde die Hebamme Betreuungen nachts, an Wochenenden oder Feiertagen übernehmen, erhielte sie für diese Zeiten einen Zuschlag in Höhe von 17 Prozent. Die (Gesamt-)Vergütung läge dann entsprechend höher.

³ Die Berechnung beruht auf der Vergütung pro Stunde von 41,40 €, die in der Schiedsstelle unstrittig war. Zum Beispiel Ausführungen des DHV: „Trotzdem liegt der aktuelle Stundensatz einer freiberuflichen Hebamme in einer nachweislichen Höhe von 41,40 € [...] Auch die Geburtspauschale von Beleghebammen (165,60 € für vier Stunden) ergibt in der Division einen Stundensatz von 41,40 €“.